



Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Ministerio de Salud y Protección Social

2026-09-28

Documento metodológico oficial | ClicSalud — Encuesta Nacional de Experiencia
del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Índice general

Presentación	7
Glosario	8
Introducción	12
1. Antecedentes	14
1.1. Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud	14
1.2. Evolución conceptual: de la percepción de calidad a la medición de la experiencia	16
1.3. Primeros antecedentes: 2003-2011	18
1.4. Consolidación de las mediciones del MSPS: 2012-2019 . . .	19
1.4.1. Evolución de la población objetivo	19
1.4.2. Evolución del diseño muestral	21
1.4.3. La medición de 2017	25
1.5. Continuidad y transformaciones de las mediciones del MSPS: 2018-2025	26
1.5.1. Comparación de las mediciones 2018-2025	27
1.5.2. 2018 — Ranking de Satisfacción EPS	30
1.5.3. 2020 — Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS	30
1.5.4. 2022 — Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS	31

1.5.5. 2023 — Encuesta con énfasis en Atención Primaria en Salud	31
1.5.6. 2024-2025 — Mediciones inmediatamente anteriores a ENUS 2026	32
1.6. Aprendizajes de las mediciones históricas	32
1.6.1. Cambios en la población incluida	33
1.6.2. Cambios en la forma de seleccionar a los usuarios	33
1.6.3. Cambios en los temas y preguntas	34
1.6.4. El cambio de modalidad de recolección en 2020	34
1.7. ENUS 2026 como nueva línea base de medición	35
1.8. Referentes internacionales para la medición de la experiencia del usuario en salud	36
1.8.1. CAHPS: medición estandarizada de la experiencia del paciente	36
1.8.2. OMS: capacidad de respuesta de los sistemas de salud	37
1.8.3. OCDE-PaRIS: experiencias y resultados reportados por los pacientes	38
1.8.4. Elementos comunes de los referentes internacionales	38
2. Objetivo de la ENUS 2026	40
2.1. Objetivo general	40
2.2. Objetivos específicos	40
3. Alcance de la operación estadística	42
3.1. Fenómenos objeto de medición	42
3.2. Población objetivo	43
3.3. Unidad de observación	44
3.4. Cobertura territorial	45
3.5. Cobertura temporal y periodo de referencia	45
3.6. Servicios de salud objeto de medición	45
3.7. Dominios de análisis	46
3.8. Límites del alcance	46

4. Diseño muestral	48
4.1. Marco muestral, invitación y no respuesta	49
4.1.1. Marco muestral	49
4.1.2. Invitación	50
4.1.3. No respuesta	51
4.2. Mecanismo de asignación de la Parte 3	52
4.2.1. Estructura de la encuesta en tres partes	53
4.2.2. Primer ingreso: sorteo, elección y asignación	53
4.2.3. Ingresos posteriores	54
4.2.4. Probabilidades y pesos de diseño de la Parte 3	54
4.2.5. Módulos de Parte 3	54
4.2.6. Diferenciación frente a las metas de respuesta	55
4.3. Determinación del tamaño de muestra	55
4.3.1. Cálculo de referencia	56
4.3.2. Ajuste por efecto de diseño	57
4.3.3. Corrección por población finita	57
4.3.4. Ajuste operativo y meta de respuesta	58
4.3.5. Parámetros adoptados	58
4.3.6. Tamaño adoptado: asignación por departamento	59
4.3.7. Distribución de la meta por celdas	62
4.3.8. Resultado agregado por región y régimen	63
4.3.9. Composición agregada de las metas	64
4.3.10. Alcance de los resultados por departamento	65
4.3.11. Conformación periódica del marco	66
4.3.12. Papel de las EPS, IPS y gestores en la invitación	66
4.3.13. Diferenciación conceptual para el análisis	67
4.3.14. Alcance de los análisis por dominio y estructura de la participación	68

5. Papel de las EPS y operativo de campo	70
5.1. ¿Qué es ClicSalud?	70
5.2. Importancia de las EPS en la operación	71
5.3. La EPS como dato de identificación del usuario	71
5.4. Participación de las EPS e IPS en la captación: sin evidencia de un canal activo	71
5.5. Métodos de difusión: recomendación metodológica	72
5.5.1. Canales propios de EPS e IPS	72
5.5.2. Canales apoyados en capacidades ya implementadas en <i>ClicSalud</i>	73
5.5.3. Coordinación institucional	73
5.5.4. Trazabilidad del canal de difusión	74
5.6. Preguntas frecuentes	74
6. Instrumento de recolección: ClicSalud	77
6.1. Estructura general de la aplicación	78
6.2. Guía de uso: recorrido completo de la aplicación	79
6.2.1. Paso 1. Mensaje institucional de bienvenida	79
6.2.2. Paso 2. Identificación por documento	80
6.2.3. Paso 3. Verificación por código SMS	81
6.2.4. Paso 4. Verificación BDUA	82
6.2.5. Paso 5. Pantalla de Inicio y navegación principal	83
6.2.6. Paso 6. Pestaña Derechos	84
6.2.7. Paso 7. Pestaña Desempeño	85
6.2.8. Paso 8. Pestaña Normas	86
6.2.9. Paso 9. Acceso al módulo Encuesta ENUS	87
6.2.10. Paso 10. Parte 2 — Preguntas comunes	88
6.2.11. Paso 11. Sorteo, elección de prestador y módulo asignado	90
6.3. Sesión y reingreso	91
6.4. Almacenamiento de datos durante la recolección	91
6.5. Alcance de esta documentación frente a otras estructuras del instrumento	92

Referencias

93

Presentación

El presente documento constituye el Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026), operación estadística del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) orientada a la medición de la experiencia de los usuarios frente a los servicios de salud.

El documento ha sido elaborado por la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social y tiene como propósito establecer y documentar los aspectos técnicos y metodológicos que sustentan el diseño, ejecución, procesamiento, análisis y generación de resultados de la operación estadística.

En este sentido, constituye el marco de referencia para la revisión técnica, validación institucional, implementación y documentación de la ENUS 2026, procurando que las diferentes etapas de la operación se desarrollen bajo criterios de coherencia metodológica, trazabilidad y reproducibilidad.

El documento presenta de manera integrada los elementos que sustentan la operación estadística, incluyendo sus objetivos, alcance, diseño estadístico, diseño de la recolección, procesamiento de la información, estrategias de estimación y validación, así como los mecanismos previstos para el control de calidad y la generación de los productos estadísticos.

La documentación se estructura de manera que permita identificar la relación entre los objetivos de la operación, las necesidades de información, los instrumentos de recolección, las variables e indicadores derivados y los procedimientos estadísticos utilizados para la producción de resultados.

Glosario

Este glosario reúne, en orden alfabético, los términos técnicos y metodológicos utilizados a lo largo del documento, con una definición breve y la referencia al capítulo donde cada concepto se desarrolla en detalle. No sustituye el desarrollo completo de cada término en su capítulo correspondiente.

Anexo E — Matriz de cuotas. Anexo externo al documento que contiene la matriz completa de las 336 celdas de cuota (región × régimen de afiliación × sexo × grupo de edad × zona), con su meta y su mínimo garantizado, organizada en una hoja por cada una de las seis regiones (4).

Árbol de decisión. Estructura que define la secuencia de preguntas, las condiciones de entrada y los saltos que sigue cada participante durante el cuestionario. Se organiza en 41 nodos distribuidos en seis bloques secuenciales (identificación y caracterización, Parte 2, sorteo Bernoulli, elección de prestador, asignación aleatoria de módulo y módulos finales) y define nueve desenlaces posibles: uno sin Parte 3 (sorteo negativo) y ocho que corresponden a un módulo asignado al azar (4).

Base analítica. Conjunto de registros que, superados los controles de validación y consistencia del procesamiento, se incorpora a la base sobre la cual se calculan los pesos y los estimadores de la operación (??).

BDUA (Base de Datos Única de Afiliados). Registro administrativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) utilizado como fuente de los totales poblacionales de referencia de ENUS 2026, tanto para determinar el tamaño objetivo de muestra como para los totales de calibración de los pesos (4).

Bloqueo de prestador. Restricción de un año calendario, contado desde que un usuario diligencia Parte 3 para un prestador determinado (EPS, IPS o gestor farmacéutico), durante la cual ese mismo prestador deja de estar disponible para que el mismo usuario lo vuelva a elegir en un ingreso posterior (4).

Calibración por entropía. Procedimiento mediante el cual el peso de referencia de cada registro se ajusta para que la muestra reproduzca los tota-

les poblacionales conocidos de un conjunto de variables auxiliares, minimizando una función de distancia de entropía sujeta a esas restricciones. Es, en un diseño de captación por cuotas como el de ENUS 2026, el mecanismo formal que sustituye a la expansión probabilística clásica (??).

ClicSalud. Aplicación digital mediante la cual se implementa la recolección de ENUS 2026: identificación del usuario, preguntas del cuestionario, validaciones y reglas de navegación (6).

Cuota. Meta de composición de la muestra fijada de antemano para cada celda de región $\times$ régimen $\times$ sexo $\times$ grupo de edad $\times$ zona, sin mecanismo aleatorio de selección dentro de la celda. Controla la composición demográfica de la captación y no equivale a un estrato, un dominio ni una variable de calibración (4).

d_i (**peso de referencia**). Valor con el que cada registro entra al proceso de calibración. En ENUS 2026 se adopta $d_i = 1$ para todo i , en ausencia de una probabilidad de inclusión conocida a partir de la cual derivar un peso $d_i = 1/\pi_i$ (??).

DEFF (efecto de diseño). Factor que ajusta el tamaño de muestra de referencia, calculado bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple, para incorporar de manera aproximada la pérdida de eficiencia asociada a la estructura del diseño. ENUS 2026 adopta $DEFF = 1,5$ (4.3).

Dominio de análisis. Agregación utilizada para la producción y publicación de resultados (nacional, regional, por régimen, por sexo, etc.). Puede coincidir en las variables que definen la cuota, pero cumple una función de reporte y estimación, no de control de la captación (4).

ENUS 2026. Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud, operación estadística del Ministerio de Salud y Protección Social adoptada como instrumento oficial y permanente mediante la Resolución 1642 de 2026 (Ministerio de Salud y Protección Social 2026) (1).

EPS, IPS y gestor farmacéutico. Actores institucionales del sistema de salud. En ENUS 2026 participan como dato de identificación del usuario en *ClicSalud* y como objeto de medición de los indicadores de desempeño que la operación está llamada a producir, sin que exista una etapa de selección probabilística a nivel institucional (5).

Estrato. En el sentido probabilístico clásico, partición de la población con selección aleatoria y probabilidad de inclusión conocida dentro de cada parte. ENUS 2026 no tiene estratos en ese sentido formal: las celdas de cuota organizan la captación, pero sin selección aleatoria dentro de ellas (4).

Experiencia del usuario. Hechos concretos ocurridos durante la interacción de la persona usuaria con los servicios de salud —distintos de una

valoración global—, entre ellos el acceso, el tiempo de espera, la humanización del trato y la entrega de medicamentos. Se mide de forma complementaria a la satisfacción (3).

Margen de error (ME) y margen de error relativo (MER). Parámetros de diseño utilizados para fijar la meta nominal de precisión del tamaño de muestra de referencia. ENUS 2026 adopta $ME = 0,0392$ y un margen de error relativo (MER) de 7,84 % (4.3).

Módulo. Bloque específico de preguntas de Parte 3 del cuestionario que responde un usuario, asignado al azar dentro del prestador que este eligió evaluar —no según el servicio efectivamente recibido—. ENUS 2026 define ocho módulos finales: EPS (3), IPS (4) y gestor farmacéutico (1) (4).

Muestreo por cuotas. Mecanismo de captación no probabilístico adoptado por ENUS 2026, en el que se establecen metas de participación para un conjunto de celdas definidas por características demográficas y de afiliación, sin selección aleatoria dentro de cada celda (4).

Peso calibrado. Peso final de cada registro, obtenido al ajustar el peso de referencia (d_i) mediante calibración por entropía contra los totales poblacionales de las variables auxiliares (??).

Población objetivo. Personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que hayan utilizado, durante alguno de los trimestres del año de referencia, al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de medición de ENUS 2026 (3.2).

Población efectivamente observada. Personas de la población objetivo que son captadas mediante los procedimientos establecidos y que proporcionan información válida para la estimación de los indicadores (3.2).

Pregunta trazadora. Cada una de las preguntas de respuesta directa que integran Parte 2 del cuestionario (preguntas comunes), tras el bloque de identificación y caracterización del usuario. A diferencia del mecanismo previo, ninguna pregunta trazadora determina por sí sola una bifurcación hacia un módulo: al terminar Parte 2 se ejecuta el sorteo Bernoulli que decide el acceso a Parte 3 (4).

Prestador (elección de). Paso del mecanismo de captación, posterior a un sorteo Bernoulli positivo, en el que el usuario elige cuál de sus prestadores habilitados y no bloqueados —EPS, IPS o gestor farmacéutico— desea evaluar. La elección del prestador no determina el módulo específico, que se asigna después al azar dentro de ese prestador (4).

Réplica (de pesos calibrados). Repetición del proceso de generación del peso de referencia y de calibración sobre una remuestra de los datos, utilizada para estimar la varianza de los estimadores a partir de la variabilidad entre las estimaciones replicadas (??).

Resto mayor (método del). Procedimiento de ajuste utilizado para que la suma de las cuotas enteras de las celdas coincida exactamente con el tamaño ya asignado a la región: el remanente entero se reparte una unidad a la vez a las celdas con mayor parte fraccionaria pendiente (4).

Ruta. Secuencia específica de nodos del árbol de decisión que recorre un usuario, desde la raíz hasta un desenlace final. ENUS 2026 define nueve desenlaces posibles según el resultado del sorteo Bernoulli, la elección de prestador y la asignación aleatoria de módulo: uno sin Parte 3 y ocho que convergen en un módulo (4).

Satisfacción. Valoración general y retrospectiva que realiza la persona usuaria sobre el servicio de salud recibido, expresando su grado de conformidad con la atención proporcionada. Se mide de forma complementaria a la experiencia del usuario (3).

SGSSS. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sorteo Bernoulli. Mecanismo probabilístico que, al terminar Parte 2, decide si un usuario en su primer ingreso accede a Parte 3: se genera $u \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ con corte $\pi = 0,8$; si $u \leq 0,8$ el usuario continúa a la elección de prestador, si $u > 0,8$ la encuesta finaliza sin Parte 3. No se ejecuta en ingresos posteriores al primero (4).

Variable auxiliar (o variable de calibración). Variable utilizada en el ajuste posterior de los pesos contra los totales de referencia de la BDUa. Puede compartir las mismas variables que la cuota (sexo, edad, régimen, zona, región), pero cumple una función distinta: corrige desbalances remanentes en la muestra ya captada (4).

Variable de clasificación. Cualquiera de las variables utilizadas por ENUS 2026 para identificar, clasificar o encausar a un usuario durante su recorrido por *ClicSalud* (documento, EPS, sexo, grupo de edad, región, zona, régimen, entidad prestadora y tipo de servicio), con su fuente, momento de obtención y uso —cuota, ruta o calibración— (??).

Introducción

La medición de la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) cuenta con antecedentes en Colombia que incluyen ejercicios desarrollados por la Defensoría del Pueblo y posteriores mediciones institucionalizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas experiencias han permitido generar evidencia sobre diferentes dimensiones de la relación de los usuarios con los servicios de salud, entre ellas el acceso, la oportunidad, el trato y la satisfacción (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020, 2022, 2023; Matajira Gaitán et al. 2018). La *Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)* se desarrolla en continuidad con estos antecedentes y busca fortalecer la generación sistemática de información sobre la experiencia de los usuarios con los servicios de salud que reciben.

La experiencia reportada por los usuarios constituye una fuente de información complementaria a los registros administrativos y a otros mecanismos de seguimiento del sistema de salud. Su medición permite identificar diferencias en la forma en que los usuarios acceden a los servicios, reciben atención, interactúan con las instituciones y valoran distintos aspectos del proceso de atención. En este sentido, la información obtenida mediante la ENUS constituye un insumo para el seguimiento y análisis de las condiciones de atención y para apoyar los procesos de evaluación y toma de decisiones en el sector salud.

La ENUS 2026 se estructura a partir de un cuestionario diseñado para recoger información sobre las diferentes dimensiones de la experiencia de los usuarios. La aplicación del instrumento se realiza mediante *ClicSalud*, herramienta de recolección en la que se implementan las preguntas, validaciones y reglas de navegación. La secuencia de aplicación se encuentra definida mediante un árbol de decisión que establece las condiciones de entrada, los saltos y las rutas que debe seguir cada participante de acuerdo con sus características y respuestas. Esta estructura permite que no todos los participantes respondan necesariamente el mismo conjunto de preguntas y que la información obtenida corresponda a la ruta aplicable a cada caso.

La captación de participantes se desarrolla mediante un mecanismo de *muestreo por cuotas* (Kish 1965; Elliott y Valliant 2017), en el que las EPS e IPS participantes actúan como canales institucionales de promoción y captación de usuarios. La clasificación de los participantes y el control de las cuotas se realizan de acuerdo con las variables y categorías definidas para la operación. Este procedimiento determina la composición objetivo de la muestra y constituye un componente central del diseño de la encuesta, por lo que sus características, reglas de asignación y mecanismos de control se documentan de manera específica.

Una vez recolectada y validada la información, se conforma la base analítica sobre la cual se aplican los procedimientos de ponderación y *calibración por entropía* (Deville y Särndal 1992; Cressie y Read 1984). Estos procedimientos permiten incorporar información auxiliar y ajustar los pesos de las observaciones de acuerdo con los totales de referencia definidos para la operación. A partir de los pesos calibrados se obtienen los estimadores de los indicadores de interés y se aplican los procedimientos establecidos para evaluar su incertidumbre (Rao y Wu 1988; Efron y Tibshirani 1993) y calidad estadística.

El presente *Documento Metodológico* describe de manera integrada los elementos que sustentan la ENUS 2026: la población objetivo y las unidades de observación, el mecanismo de captación y clasificación de los participantes, y el diseño y control de las cuotas. Documenta, además, la estructura y aplicación del cuestionario y el árbol de decisión que determina sus rutas; el procesamiento y validación de la información recolectada; la construcción y calibración de los pesos; y la estimación de los indicadores junto con los procedimientos para evaluar su incertidumbre y calidad.

La organización del documento sigue la secuencia metodológica de la operación. Los primeros capítulos presentan la identidad y caracterización de la ENUS 2026, establecen su marco general y describen la población objetivo, el diseño de la encuesta, el mecanismo de captación, el instrumento de recolección y la estructura lógica del cuestionario. Los capítulos centrales desarrollan los procedimientos de procesamiento, ponderación, calibración y estimación, así como la metodología para evaluar la incertidumbre y la calidad estadística de los resultados. El documento cierra con las principales limitaciones de la operación y los anexos técnicos que detallan el cuestionario, el árbol de decisión, las cuotas, los indicadores y las matrices de trazabilidad.

En conjunto, el documento constituye el referente metodológico para comprender cómo se estructura la ENUS 2026, cómo se recolecta y procesa la información, y cómo esta se transforma en los resultados estadísticos de la operación.

Capítulo 1

Antecedentes

Este capítulo tiene tres propósitos: presentar la evolución de las mediciones sobre la percepción de calidad, la satisfacción y la experiencia de los usuarios del sistema de salud colombiano entre 2005 y 2025; identificar los principales antecedentes nacionales e internacionales que sirven de referencia para la ENUS 2026; y recoger los principales aprendizajes derivados de estas experiencias.

Estos antecedentes sirven como contexto para el diseño de la ENUS 2026, pero no definen por sí mismos las decisiones metodológicas de la encuesta. Los aspectos relacionados con el diseño muestral, el instrumento, el procesamiento, la ponderación y la estimación se presentan en los capítulos correspondientes.

Para la elaboración de este capítulo se revisaron los documentos originales de las principales mediciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las fuentes utilizadas para los antecedentes nacionales e internacionales. Cuando alguna información no pudo ser comprobada directamente en las fuentes disponibles, se señala para su posterior verificación.

1.1 Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud

La medición de la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) no es una iniciativa aislada: se inscribe en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), que constituye el marco reglamentario bajo el cual

el sector salud genera, mantiene y mejora la calidad de los servicios. El SOGCS fue establecido originalmente mediante el Decreto 1011 de 2006 (Ministerio de la Protección Social 2006) y sus disposiciones fueron posteriormente compiladas —sin modificación sustantiva de su contenido— en el Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, que hoy constituye la norma reglamentaria vigente en la materia (Ministerio de Salud y Protección Social 2016a). Por esta razón, las referencias normativas de este documento se hacen al Decreto 780 de 2016, señalando cuando corresponda su origen en el Decreto 1011 de 2006.

De acuerdo con el Decreto 780 de 2016, las acciones del SOGCS se orientan al mejoramiento de los resultados de la atención en salud centrados en el usuario, superando la verificación aislada de la existencia de estructuras o de la documentación de procesos, los cuales constituyen únicamente prerrequisitos para alcanzar dichos resultados. Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención, la norma define cinco características esenciales: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. Dos de ellas resultan directamente constitutivas del objeto de medición de ENUS 2026. La accesibilidad se define como la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el SGSSS; la oportunidad, como la posibilidad de obtener los servicios requeridos sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Ambas dimensiones son retomadas explícitamente por el marco conceptual de este documento para definir la experiencia del usuario (véase la Sección 3.1).

Estructuralmente, el SOGCS se articula en cuatro componentes: el Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad (SIC). Este último es el componente de anclaje directo de ENUS 2026, en tanto define los mecanismos mediante los cuales el sistema produce, reporta y difunde información sobre la calidad de los servicios desde la perspectiva del usuario. La Resolución 256 de 2016 desarrolló este componente al establecer las disposiciones del SIC y definir el conjunto de indicadores de monitoreo de la calidad, bajo un enfoque orientado al mejoramiento continuo y al impacto sobre los usuarios (Ministerio de Salud y Protección Social 2016c). Es en este mismo componente donde se enmarcan las mediciones institucionales previas del Ministerio —incluidas las encuestas de evaluación de los servicios de las EPS, según lo declaran expresamente sus respectivos informes metodológicos (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020)—, lo que permite leer ENUS 2026 como continuidad y no como ruptura respecto de la serie de mediciones anteriores descritas en este capítulo.

Sobre esa base normativa acumulada, la medición de la satisfacción y de las dimensiones asociadas a la interacción de las personas con el sistema de salud ha operado durante casi dos décadas como mecanismo regular

de seguimiento de la calidad. Estas mediciones constituyen el antecedente institucional de una ampliación conceptual de mayor alcance: la incorporación, junto a la medición de satisfacción —construida sobre juicios evaluativos globales del usuario—, de una medición de experiencia del usuario, que documenta ocurrencias concretas y verificables en dimensiones como el acceso, la oportunidad, la continuidad, el trato recibido y la resolución efectiva de la necesidad en salud.

Esta evolución se consolida formalmente con la Resolución 1642 de 2026, que establece lineamientos para la Carta de Derechos y Deberes de las personas afiliadas al SGSSS y adopta la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS) como instrumento oficial para la medición de la experiencia del usuario (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Dicha resolución constituye el acto administrativo que confiere a ENUS 2026 su carácter de operación estadística institucional y define su alcance dentro del SIC.

En síntesis, el marco normativo de ENUS 2026 opera en tres niveles jerárquicos y complementarios: el SOGCS (Decreto 780 de 2016, que compila el Decreto 1011 de 2006) aporta el marco general de calidad y el mandato de orientación al usuario, junto con las definiciones de accesibilidad y oportunidad que la encuesta operacionaliza; el Sistema de Información para la Calidad (Resolución 256 de 2016) establece los mecanismos de monitoreo, los indicadores y las obligaciones de reporte; y la Resolución 1642 de 2026 adopta la ENUS como el instrumento específico mediante el cual se materializa la medición de la experiencia del usuario en salud. Este encadenamiento normativo es el fundamento institucional que sostiene la existencia, la periodicidad y la exigibilidad de las mediciones de experiencia del usuario en el sistema de salud colombiano.

1.2 Evolución conceptual: de la percepción de calidad a la medición de la experiencia

Las mediciones realizadas en Colombia a lo largo del período revisado no han abordado necesariamente el mismo objeto de medición que la ENUS 2026. Se observa una evolución progresiva desde mediciones centradas en la percepción de la calidad y la satisfacción hacia un enfoque que busca caracterizar de manera más amplia la experiencia de las personas durante su interacción con los servicios de salud.

Esta evolución puede entenderse a partir de tres enfoques relacionados, pero conceptualmente diferenciables:

1. **Percepción de calidad.** Las mediciones asociadas con PECASUSS se orientaron a conocer la valoración que los usuarios realizaban sobre

la calidad de los servicios recibidos (Ministerio de la Protección Social 2008). Este enfoque constituye uno de los antecedentes de la medición de la calidad desde la perspectiva de los usuarios en Colombia.

2. **Satisfacción.** Las mediciones desarrolladas posteriormente por la Defensoría del Pueblo y, de manera sistemática, por el Ministerio de Salud y Protección Social, incorporaron la satisfacción como una medida de valoración de los usuarios respecto de los servicios y de las entidades responsables de su atención (Defensoría del Pueblo de Colombia 2009; Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025; Matajira Gaitán et al. 2018). Estas mediciones permitieron realizar seguimiento a la percepción de los usuarios y generar información para el monitoreo de la calidad de los servicios.
3. **Satisfacción y experiencia del usuario.** La ENUS 2026 mide ambos fenómenos de manera complementaria: una valoración global de satisfacción, en continuidad con la serie histórica, y un conjunto de dimensiones específicas de experiencia —hechos concretos de la interacción de las personas con el sistema y los servicios de salud, distintos de esa valoración global—. La definición de cada concepto y las dimensiones específicas de experiencia se desarrollan en el marco conceptual de este documento (3.1).

Los referentes internacionales contribuyen a esta evolución conceptual. Instrumentos como CAHPS, el enfoque de *responsiveness* desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y el programa PaRIS de la OECD muestran diferentes formas de medir aspectos de la atención desde la perspectiva de las personas que utilizan los servicios. Estos referentes incorporan dimensiones específicas de la interacción con los servicios y permiten avanzar desde una valoración general hacia mediciones más desagregadas de la experiencia.

En este documento se conserva la terminología utilizada en las fuentes originales. Por esta razón, las mediciones anteriores se presentan como mediciones de percepción de calidad o satisfacción cuando ese es el concepto utilizado por sus respectivos instrumentos, y no se homologan retrospectivamente como mediciones de experiencia del usuario.

Esta precisión es importante porque algunos instrumentos anteriores incorporaron el término “experiencia” en determinadas preguntas o indicadores. Por ejemplo, documentos del ciclo de mediciones del Ministerio de Salud y Protección Social utilizan expresiones relacionadas con la experiencia global de los usuarios (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2023). Sin embargo, el uso del término en una pregunta particular no implica necesariamente que toda la operación haya tenido como objeto una medición multidimensional de la experiencia del usuario.

En este sentido, los antecedentes presentados en este capítulo no deben interpretarse como una serie de mediciones homogéneas del mismo indicador. Constituyen, más bien, el proceso mediante el cual el sistema de salud colombiano ha desarrollado diferentes mecanismos para conocer la percepción, satisfacción y experiencia de los usuarios. La ENUS 2026 se desarrolla sobre este recorrido y establece la satisfacción y la experiencia del usuario como objetos explícitos y complementarios de medición, de acuerdo con el marco conceptual y normativo que se presenta en los capítulos siguientes.

1.3 Primeros antecedentes: 2003-2011

Entre los primeros antecedentes identificados se encuentran las evaluaciones realizadas por la *Defensoría del Pueblo* y el desarrollo del instrumento *PECASUSS (Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud)*. Estas experiencias constituyen antecedentes importantes para la posterior incorporación de mediciones sistemáticas de la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de salud.

Defensoría del Pueblo. En los documentos del Ministerio de Salud y Protección Social revisados para este capítulo se menciona una evaluación de los servicios de las EPS desde la perspectiva de los usuarios, atribuida a la Defensoría del Pueblo y correspondiente al año 2005 (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020). Sin embargo, no fue posible localizar ni validar la fuente primaria de esta evaluación; por tanto, se presenta únicamente como un antecedente mencionado en la documentación institucional, sin atribuirle un alcance o contenido específico.

El entonces Ministerio de la Protección Social desarrolló el instrumento *PECASUSS* para evaluar la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios en el marco del Programa de Reestructuración de Redes de Servicios de Salud (Ministerio de la Protección Social 2008). De acuerdo con los antecedentes documentados por el Ministerio, el instrumento fue aplicado en una medición de línea de base y una medición de seguimiento, correspondientes a 2006 y 2008, respectivamente (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020).

A diferencia de las evaluaciones de satisfacción que se desarrollarían posteriormente, *PECASUSS* se centró en la **percepción de la calidad de los servicios** y estuvo dirigido a las instituciones intervenidas por el programa. Por tanto, constituye un antecedente relevante de la medición de la calidad desde la perspectiva de los usuarios, aunque su alcance y objeto de medición fueron diferentes a los de las encuestas posteriores del Ministerio.



1.4 Consolidación de las mediciones del MSPS: 2012-2019

A partir de 2012 el MSPS institucionalizó una medición anual de la satisfacción de los usuarios, inscrita en el **Sistema de Información para la Calidad (SIC)**, a diferencia de los ejercicios previos de la Defensoría del Pueblo (2005) y de PECASUSS (2006 y 2008), desarrollados antes de la creación del SIC. La serie comprende las mediciones realizadas entre 2012 y 2019 (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020).

La continuidad institucional de esta serie no implica que sus características metodológicas hayan permanecido constantes. Durante el período se presentan cambios en la población objetivo, los criterios de inclusión y exclusión, los marcos muestrales, las unidades de estratificación y los criterios utilizados para determinar el tamaño y la precisión de las muestras. Estas diferencias son relevantes para interpretar la evolución de los resultados y para establecer comparaciones con ENUS 2026.

1.4.1 Evolución de la población objetivo

Año	Población objetivo declarada	Periodo de referencia	Exclusiones	Muestra efectiva	Fuente
2012	No disponible	—	—	—	—
2013	No disponible	—	—	—	—
2014	Ciudadanos usuarios de servicios de las EPS, solo población mayor de 18 años	Últimos 6 meses	Regímenes especiales y exentos	20.361 encuestas efectivas, en 85 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Ministerio de Salud y Protección Social (2016b)

Año	Población objetivo declarada	Periodo de referencia	Exclusiones	Muestra efectiva	Fuente
2015	Ciudadanos usuarios de servicios de las EPS, incluidos menores de edad	Últimos 6 meses	Regímenes especiales (FFMM, Policía, Ecope-trol) y exentos (universidades públicas)	29.761 encuestas efectivas (54.852 contactos), en 73 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Consultores en In-formación mé-trika S.A.S. (2015)
2016	Afiliados al SGSSS con uso de servicio en 6 meses previos; excluye regímenes especiales, medicina prepagada y planes complementarios	Últimos 6 meses	Regímenes especiales; medicina prepa-gada, plan comple-mentario	26.502 encuestas efectivas (81.049 contactos), en 95 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Ministerio de Sa-lud y Pro-tec-ción So-cial (2016b)
2017	Afiliados al SGSSS que usaron servicios de su EPS, todas las edades , urbano y rural (centros poblados)	Últimos 6 meses	Regímenes especiales y exen-tos; medi-cina prepa-gada, plan comple-mentario y seguro privado	24.586 encuestas efectivas, en 95 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Ministerio de Sa-lud y Pro-tec-ción So-cial (2017)
2018-2019	No disponible	—	—	—	—

La población incluida en las mediciones no fue exactamente la misma durante todo el periodo. Se identifican dos cambios importantes, ambos documentados en la sección de antecedentes de la encuesta técnica de 2016, que compara explícitamente las tres ediciones (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b).

- *La incorporación de menores de edad en 2015.* Hasta 2014, las encuestas consideraban únicamente a las personas mayores de 18 años. A partir de 2015 se incluyeron también los menores de edad; en 2016 la encuesta también cubrió a toda la población, sin restricción de edad (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b). Este cambio amplió de manera importante el número de personas que podían participar en la encuesta: el universo de estudio pasó de 11.425.380 personas en 2014 a 16.555.627 en 2015 (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015). Por esta razón, las diferencias observadas entre estos dos años no pueden interpretarse únicamente como cambios en la satisfacción de los usuarios, ya que también cambió el grupo de personas al que se referían los resultados —advertencia que hacen explícitamente tanto el informe de 2014-2015 como el propio informe de 2016 (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015; Ministerio de Salud y Protección Social 2016b).
- *Los cambios en las personas excluidas de la encuesta.* En las ediciones de 2014 y 2016 se excluyeron los afiliados a regímenes especiales y exentos, y a partir de 2017 se agregaron exclusiones relacionadas con quienes contaban con medicina prepagada, planes complementarios o seguros privados de salud (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b, 2017). Estos cambios hicieron que el grupo de personas al que se referían los resultados no fuera exactamente el mismo en todos los años.

Por estas razones, los resultados de las encuestas realizadas entre 2012 y 2019 no deben interpretarse como una serie completamente homogénea. Al compararlos con la ENUS 2026 será necesario tener en cuenta quiénes fueron incluidos en cada medición y bajo qué condiciones se realizaron las encuestas.

1.4.2 Evolución del diseño muestral

Los cambios en la población objetivo estuvieron acompañados por modificaciones en el diseño muestral. Aunque las **EPS permanecieron como unidad de análisis**, la unidad de estratificación y la organización de las etapas de selección cambiaron entre las diferentes ediciones.

Año	Diseño declarado	Unidad de estratificación	Etapas y unidades de muestreo	Marco muestral	Criterio de tamaño y precisión	Fuente
2012	No disponible	—	—	—	—	—
2013	No disponible	—	—	—	—	—
2014	Probabilístico	—	—	—	—	—
2015	de conglomerados	declarada	Unidades de selección: secciones cartográficas DANE. Unidades de análisis: cada EPS	Tres marcos completos: mentarios: dos de áreas (DANE 2005, actualización 2012, y catastro) y uno de lista, provisto por el MSPS, para EPS de muy baja participación	Variable trazadora tipo proporción con $P = 50\%$; error máximo esperado inferior al 5 % para proporciones de mínimo 50 %	Consultores en formación In-formétrica S.A.S. (2015)



Año	Diseño declarado	Unidad de estratificación	Etapas y unidades de muestreo	Marco muestral	Criterio de tamaño y precisión	Fuente
2016	Probabilístico multi-etápico, estratificado y de conglomerados (mismo diseño que 2017)	Grupos de municipios según categoría DNP (tres estratos)	1. ^a municipios (32 capitales de inclusión forzosa, 23 de categoría 1-5 DNP y 40 de categoría 6, estos dos últimos con probabilidad proporcional al tamaño); 2. ^a manzanas; 3. ^a personas	Lista de municipios con caracterización; áreas de manzanas sobre cartografía censal DANE; lista de miembros del hogar levantada en campo	26.502 encuestas efectivas (81.049 contactos), 18 % sobre la meta fijada por el Ministerio	Ministerio de Salud y Protección Social (2016b)

Año	Diseño declarado	Unidad de estratificación	Etapas y unidades de muestreo	Marco muestral	Criterio de tamaño y precisión	Fuente
2017	Probabilístico multi-etápico, estratificado y de conglomerados	Grupos de municipios según categoría DNP (tres estratos)	1. ^a municipios; 2. ^a manzanas (proporcional a hogares); 3. ^a personas. Unidad de análisis: EPS	Lista de municipios con caracterización; áreas de manzanas sobre cartografía censal DANE (Censo 2005, actualización 2012); lista de miembros del hogar levantada en campo	Error relativo inferior al 5 % para proporciones superiores al 20 %, nacional y por nivel de desagregación	Ministerio de Salud y Protección Social (2017)
2018	No disponible	—	—	—	—	—
2019	No disponible	—	—	—	—	—

La comparación de las ediciones documentadas muestra tres cambios importantes en la forma en que se organizaron las encuestas.

- *El diseño de 2016 fue heredado, no reinventado, por la edición 2017.* Las ediciones 2016 y 2017 comparten exactamente los mismos tres

estratos DNP y los mismos 95 municipios como unidades primarias de muestreo (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b, 2017), lo que indica que la arquitectura de estratificación territorial se fijó en 2016 y se mantuvo sin cambios en la edición siguiente. En ambas, la selección comenzó por los municipios, agrupados según su categoría DNP, y posteriormente se seleccionaron manzanas y personas dentro de esos territorios.

- *También cambió el criterio para determinar el tamaño y la precisión de las muestras.* En las mediciones de 2014-2015 se utilizó un criterio basado en una proporción esperada del 50 % y un error máximo inferior al 5 % (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015). En 2017 se estableció un error relativo inferior al 5 % para proporciones superiores al 20 % (Ministerio de Salud y Protección Social 2017). Estos criterios no son directamente comparables, por lo que las diferencias en la precisión de los resultados entre años deben interpretarse con cautela. La fuente de 2016 no documenta un criterio de precisión comparable a los anteriores, más allá de reportar el porcentaje de encuestas logradas sobre la meta fijada (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b).
- *El marco de área se mantuvo basado en información censal de 2005.* Tanto las mediciones de 2014-2015 como la de 2017 utilizaron cartografía del DANE correspondiente al Censo General 2005, actualizada a la vigencia 2012 (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015; Ministerio de Salud y Protección Social 2017). Esto significa que, aunque las encuestas se realizaron varios años después del censo, la selección de los hogares partía de esa estructura territorial. Esta característica es importante al analizar la cobertura de las encuestas y la forma en que representaban a la población en cada momento.

1.4.3 La medición de 2017

La **Encuesta Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS 2017** (Ministerio de Salud y Protección Social 2017) constituye un punto importante dentro de esta evolución. Se enmarca explícitamente en el SOGCS y dentro del SIC, en línea con el marco normativo de la Sección 1.1, y adoptó un diseño **probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados**, con tres etapas anidadas:

- *Primera etapa — municipios.* El marco estuvo constituido por una lista de los municipios del país con información de caracterización, entre ella cantidad de afiliados, clasificación DNP y número de EPS con afiliados en el municipio. El territorio se estratificó en tres grupos según la categoría municipal DNP: 32 municipios capitales de departamento, incluida Bogotá D.C.; 23 municipios de categoría 1 a 5; y 40

municipios de categoría 6. En total, 95 municipios constituyeron las unidades primarias de muestreo.

- *Segunda etapa — manzanas.* Dentro de cada municipio seleccionado se realizó la selección de manzanas con probabilidad proporcional a la cantidad de hogares. El marco de áreas se construyó sobre la cartografía censal del DANE, con los polígonos de sector, sección y manzana y la información de viviendas, hogares y personas del Censo General 2005, actualizada a la vigencia 2012. En las áreas rurales el marco correspondió a las manzanas urbanas de los centros poblados de los municipios seleccionados.
- *Tercera etapa — personas.* El marco estuvo constituido por una lista de los miembros del hogar construida durante la recolección. Sobre este listado se seleccionó **una persona** que hubiera utilizado los servicios de salud en los seis meses previos. Para los menores de edad se solicitó como informante al adulto que acompañaba al menor al servicio de salud.

Las unidades de análisis fueron las EPS y los niveles de desagregación previstos correspondieron al régimen, la EPS y el departamento. El operativo se realizó entre julio y agosto de 2017, mediante entrevista personal cara a cara con un cuestionario estructurado de 60 preguntas organizadas en 18 capítulos. Se obtuvo una muestra efectiva de 24.586 encuestas en 95 municipios de los 32 departamentos y el Distrito Capital, a partir de la cual los resultados se infirieron a una población estimada de 16.815.482 usuarios. La precisión declarada correspondió a un error relativo inferior al 5 % para proporciones superiores al 20 %.

El cuestionario articuló siete ejes temáticos: **satisfacción, oportunidad, acceso, trato digno, respuesta, caracterización del usuario y corresponsabilidad del usuario** (Ministerio de Salud y Protección Social 2017). Varios de estos temas reaparecen, con una definición propia, entre las dimensiones de experiencia del usuario del marco conceptual de este documento (3.1). La encuesta de 2017 constituye así un antecedente importante de la incorporación progresiva de dimensiones relacionadas con la interacción de los usuarios con los servicios de salud, aunque su objeto principal continuaba siendo la evaluación de los servicios de las EPS y la satisfacción de sus usuarios.

1.5 Continuidad y transformaciones de las mediciones del MSPS: 2018-2025

Entre 2018 y 2025 las mediciones del MSPS mantuvieron la evaluación de la satisfacción de los usuarios como eje principal, pero incorporaron cam-

bios en los instrumentos, los temas abordados y las formas de recolección. En este periodo se observan además dos momentos particulares: la modificación del operativo durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y el retorno a la recolección presencial en 2022. Las mediciones de 2023, 2024 y 2025 muestran la continuidad de la serie hasta los años inmediatamente anteriores a la ENUS 2026.

1.5.1 Comparación de las mediciones 2018-2025

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2018	Ranking de Satisfacción EPS	Satisfacción, oportunidad y trámites	Análisis secundario de la información de 2017	Información de 2017	51 indicadores agrupados en tres dimensiones: oportunidad, satisfacción y trámites. Incorporación de <i>boots-trapping</i> para comparar diferencias entre EPS

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2020	Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS	Evaluación de servicios y satisfacción	Entrevista telefónica; muestreo de lista	18.630 personas, 36 EPS	Cambio del muestreo de áreas a muestreo de lista. Ampliación de 157 a 541 municipios por las dificultades de respuesta telefónica. Inclusión de módulo sobre COVID-19
2022	Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS	Satisfacción, acceso, recomendación y trámites	Entrevista presencial; selección aleatoria de barrios y manzanas y barrido de hogares	18.360 encuestas	Retorno a la recolección presencial. Resultados expandidos a 42.897.182 personas

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2023	Encuesta con énfasis en Atención Primaria en Salud	Satisfacción y atención primaria en salud	Probabilístico, estratificado, de conglomerados y trietápico; entrevista presencial	14.845 encuestas válidas (mín. contractual 12.096)	Selección de municipios, sectores censales y personas. Desagregación en seis macrorregiones. Instrumento de aproximadamente 75 preguntas
2024	Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano	Satisfacción de los usuarios	Diseño no documentado en los antecedentes revisados	—	Continuidad de la medición de satisfacción. El título oficial no incorpora el énfasis en atención primaria de 2023

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2025	Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano	Satisfacción de los usuarios	Diseño no documentado en los antecedentes revisados	18.639 usuarios	Levantamiento entre septiembre y diciembre. Cobertura en seis regiones del sistema de salud

1.5.2 2018 --- Ranking de Satisfacción EPS

La edición de 2018 (Matajira Gaitán et al. 2018) no correspondió a una nueva encuesta, sino a un análisis de la información obtenida en 2017. El cambio principal estuvo en la forma de organizar y presentar los resultados: la dimensión de acceso fue sustituida por la dimensión de trámites y se construyó un ranking a partir de 51 indicadores agrupados en tres dimensiones con igual ponderación: oportunidad (33,3 %), satisfacción (33,3 %) y trámites (33,3 %).

Para comparar los resultados entre EPS se utilizó un procedimiento de remuestreo (*bootstrapping*) que replicó el ejercicio 1.000 veces y permitió establecer un umbral para determinar cuándo las diferencias entre los puntajes podían considerarse estadísticamente significativas (Matajira Gaitán et al. 2018).

1.5.3 2020 --- Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS

La medición de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social 2020) estuvo marcada por las condiciones generadas por la pandemia de COVID-19. La encuesta, que tradicionalmente se realizaba mediante entrevistas presenciales, pasó a realizarse por vía telefónica. Este cambio estuvo acompañado por una modificación del diseño muestral: se pasó de un muestreo de áreas a un muestreo de lista (Ministerio de Salud y Protección Social 2020).

Las dificultades para obtener las entrevistas previstas llevaron a ampliar la cobertura inicialmente establecida de 157 a 541 municipios. Finalmente

se realizaron 18.630 encuestas a usuarios de 36 EPS en los 33 departamentos (Ministerio de Salud y Protección Social 2020). La encuesta incorporó además un módulo específico sobre diagnóstico y atención relacionados con COVID-19.

El cambio en la modalidad de recolección constituye uno de los principales elementos metodológicos de esta edición, ya que modifica la forma de contacto con los usuarios y el marco utilizado para seleccionarlos.

1.5.4 2022 --- Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS

La medición de 2022 (Ministerio de Salud y Protección Social 2022) retomó la recolección presencial. La selección se realizó mediante una combinación de selección aleatoria de barrios y manzanas, apoyada en cartografía, y un barrido de hogares dentro de las manzanas seleccionadas. Cuando no se alcanzaba la cantidad de encuestas prevista en una manzana, se realizaba el reemplazo por otra manzana (Ministerio de Salud y Protección Social 2022).

El trabajo de campo se desarrolló entre el 2 de agosto y el 31 de octubre de 2022. Se realizaron 18.360 encuestas: 7.325 correspondientes al régimen contributivo, 9.574 al régimen subsidiado y 1.461 al régimen subsidiado/indígena. Los resultados fueron expandidos a 42.897.182 personas, sobre un universo de 48.899.985 afiliados a las EPS con corte a septiembre de 2022, equivalente a una cobertura del estudio del 87,72 % (Ministerio de Salud y Protección Social 2022).

El instrumento abordó aspectos relacionados con las características de los afiliados, satisfacción global, acceso, recomendación, estado de salud y trámites. Esta estructura muestra la continuidad de algunos temas de las mediciones anteriores, junto con una reorganización del contenido del cuestionario.

1.5.5 2023 --- Encuesta con énfasis en Atención Primaria en Salud

La medición de 2023 (Ministerio de Salud y Protección Social 2023) incorporó un énfasis explícito en la **Atención Primaria en Salud**, aspecto que se refleja tanto en el título como en el contenido del informe. El diseño fue **probabilístico, estratificado, de conglomerados y trietápico**, con selección de municipios, sectores censales y personas, mediante entrevista personal en los hogares.

El instrumento tuvo aproximadamente 75 preguntas y la presentación de los resultados incorporó seis macrorregiones: **Pacífico, Caribe, Central,**

Oriental, Bogotá y Orinoquía-Amazonía (Ministerio de Salud y Protección Social 2023). Esta desagregación amplió la forma de presentar los resultados frente a las ediciones anteriores.

Los principales elementos de diseño y muestra de esta edición se presentan en la tabla comparativa de la Sección 1.5.1; los aprendizajes metodológicos que deja el conjunto del ciclo se sintetizan en la Sección 1.6.

1.5.6 2024-2025 --- Mediciones inmediatamente anteriores a ENUS 2026

Las mediciones de 2024 y 2025 corresponden a las etapas más recientes de la serie de encuestas de satisfacción desarrolladas por la Oficina de Calidad del MSPS (Ministerio de Salud y Protección Social 2024, 2025).

En 2024, el informe se presentó bajo el título **“Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2024”** (Ministerio de Salud y Protección Social 2024). A diferencia de la edición 2023, el título no incorpora una mención específica a la Atención Primaria en Salud, por lo que este énfasis debe entenderse como una característica particular de la medición de 2023.

Para 2025, el informe documenta un levantamiento realizado entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre, con **18.639 usuarios encuestados** en seis regiones del sistema de salud (Ministerio de Salud y Protección Social 2025). Los resultados muestran que el 53 % de las respuestas calificó la satisfacción como “buena” y el 10 % como “muy buena”; el 28 % respondió “ni buena ni mala” y el 8 % correspondió a las categorías negativas. En 18 de las 26 EPS evaluadas se registró una disminución de la satisfacción frente al año anterior (Ministerio de Salud y Protección Social 2025).

Estas mediciones constituyen los antecedentes más recientes de ENUS 2026 y muestran la continuidad de la medición de satisfacción de los usuarios hasta el periodo inmediatamente anterior a la nueva encuesta.

1.6 Aprendizajes de las mediciones históricas

Las mediciones realizadas entre 2005 y 2025 constituyen un antecedente importante para la ENUS 2026 y muestran una trayectoria institucional sostenida del Ministerio de Salud y Protección Social en el seguimiento de la percepción y satisfacción de los usuarios frente a los servicios de salud. Durante este periodo se desarrollaron diferentes ejercicios de medición que permitieron conocer la valoración de los usuarios e incorporar progresivamente nuevos temas relacionados con su interacción con el sistema de salud.

Sin embargo, estas mediciones no fueron realizadas bajo condiciones constantes. A lo largo del periodo cambiaron la población incluida, el periodo de referencia, la forma de seleccionar a los participantes, los instrumentos, los temas evaluados y las modalidades de recolección. En consecuencia, los resultados publicados para los diferentes años no constituyen una única serie estadística homogénea.

Esta diferencia es fundamental para interpretar los resultados históricos. Una variación observada entre dos años puede reflejar un cambio real en la percepción de los usuarios, pero también puede estar relacionada con modificaciones en las personas incluidas en la encuesta, la forma en que fueron seleccionadas, las preguntas utilizadas o las condiciones en las que se realizó la recolección.

1.6.1 Cambios en la población incluida

La población considerada en las mediciones no permaneció constante. Hasta 2014, las mediciones documentadas se concentraban en personas mayores de 18 años, mientras que desde 2015 se incorporaron también los menores de edad. También cambiaron las condiciones de inclusión y exclusión de los usuarios y, en algunas ediciones, el periodo utilizado para determinar si una persona había utilizado los servicios de salud.

El cambio ocurrido entre 2014 y 2015 es especialmente ilustrativo. La inclusión de menores de edad amplió el grupo de personas al que se referían los resultados. El universo de estudio pasó de 11.425.380 usuarios en 2014 a 16.555.627 en 2015. Por esta razón, una diferencia en los resultados entre estos dos años no puede interpretarse directamente como un cambio en la satisfacción de los usuarios, ya que también cambió la población a la que se referían esos resultados.

Algo similar ocurrió con las exclusiones. A lo largo de la serie se incorporaron diferentes grupos que no fueron considerados en las mediciones, entre ellos afiliados a regímenes especiales, personas con medicina prepagada, planes complementarios o seguros privados. Como resultado, el grupo de personas representado por los resultados fue cambiando con el tiempo.

1.6.2 Cambios en la forma de seleccionar a los usuarios

También cambió la forma en que se seleccionaron las personas que participaron en las encuestas. En 2017, por ejemplo, la muestra se construyó mediante la selección de municipios, manzanas y personas, mientras que en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se pasó de un diseño basado en áreas a uno basado en listas de afiliados y se sustituyó la entrevista presencial por entrevistas telefónicas.

En 2022 se retomó la recolección presencial, mediante selección de barrios y manzanas y un barrido de hogares. En 2023 nuevamente se implementó un diseño probabilístico trietápico.

Estos cambios pueden modificar la composición de las personas que finalmente participan en la encuesta y la forma en que los resultados representan a la población. Por ello, aun cuando dos mediciones utilicen preguntas similares, sus resultados no necesariamente son directamente comparables.

1.6.3 Cambios en los temas y preguntas

La comparabilidad también se ve afectada por los cambios en el contenido de las mediciones.

Las primeras experiencias estuvieron orientadas a la percepción de calidad y, posteriormente, las mediciones del MSPS se concentraron principalmente en la satisfacción de los usuarios. Dentro de este ciclo también cambiaron los temas incluidos y la forma de organizar los resultados. El ranking de 2018, por ejemplo, reorganizó los indicadores de la medición de 2017 y sustituyó la dimensión de acceso por trámites. En 2023 se incorporó un énfasis explícito en atención primaria en salud.

Esto significa que los resultados de diferentes años no siempre representan exactamente el mismo aspecto de la relación entre los usuarios y el sistema de salud. Por tanto, observar que un porcentaje aumentó o disminuyó entre dos años no es suficiente para concluir que existe una tendencia histórica de mejora o deterioro.

1.6.4 El cambio de modalidad de recolección en 2020

La medición de 2020 constituye un punto particularmente importante de esta trayectoria. La pandemia obligó a sustituir la entrevista presencial por la entrevista telefónica y llevó a modificar el diseño muestral. La cobertura inicialmente prevista de 157 municipios tuvo que ampliarse a 541 municipios debido a las dificultades para alcanzar el número de entrevistas requerido.

Este cambio no fue únicamente operativo. La modificación de la forma de contactar a los usuarios y del marco utilizado para seleccionarlos cambió las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados. Por esta razón, los resultados de 2020 deben interpretarse dentro de las condiciones particulares de esa medición y no como una observación completamente equivalente a las mediciones presenciales anteriores o posteriores.

1.7 ENUS 2026 como nueva línea base de medición

En conjunto, las mediciones históricas muestran una trayectoria institucional importante y permiten identificar los temas que han sido relevantes para los usuarios, así como los principales aprendizajes relacionados con la población estudiada, el diseño de las encuestas, la recolección y la construcción de los indicadores. Al mismo tiempo, las diferencias acumuladas entre las distintas ediciones hacen que **la serie 2005-2025 no sea adecuada para establecer una única línea de tendencia de satisfacción o experiencia del usuario**: los resultados de cada operación conservan su valor como evidencia histórica, pero no deben interpretarse como observaciones sucesivas de una misma encuesta realizada bajo condiciones constantes.

A esta discontinuidad metodológica se suma una discontinuidad normativa. Las mediciones descritas en este capítulo corresponden a ejercicios sucesivos del Ministerio de Salud y Protección Social, cada uno con su propia ficha técnica, sin un marco normativo específico que los articulara como una única serie. ENUS 2026, en cambio, cuenta con un fundamento normativo propio: la Resolución 1642 de 2026, expedida el 31 de julio de 2026, adopta la **Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS)** como instrumento oficial y establece que su naturaleza es permanente y continua. La resolución define la ENUS como un instrumento digital para recoger información sobre la experiencia del afiliado frente a los servicios recibidos, y dispone que su diseño metodológico debe garantizar la representatividad estadística, el control sobre la generación de la información, la comparabilidad de los resultados en el tiempo y la reducción de los sesgos asociados a la autoselección de los participantes (Ministerio de Salud y Protección Social 2026).

La resolución establece además que la ENUS debe generar información sobre el desempeño de las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos, mediante indicadores organizados de acuerdo con los atributos de calidad definidos en la normativa vigente. El Ministerio deberá establecer mediante lineamientos técnicos los indicadores, sus fuentes, periodicidad y metodología de cálculo, así como los estándares técnicos necesarios para la operación del aplicativo y el intercambio de información (Ministerio de Salud y Protección Social 2026).

Por estas dos razones —metodológica y normativa—, la ENUS 2026 no debe entenderse como una nueva edición de las encuestas históricas de satisfacción, sino como el **punto de partida de una nueva serie de medición de la satisfacción y la experiencia del usuario en salud**. La primera medición establecerá la línea base sobre la cual se realizarán las mediciones posteriores.

Para que esta nueva serie sea comparable, la ENUS 2026 debe mantener

estables, desde su primera aplicación, una definición clara de la población objetivo, un diseño muestral documentado, procedimientos reproducibles de selección y ponderación, un instrumento estructurado a partir de una definición estable de experiencia del usuario, y reglas claras para el procesamiento, estimación y cálculo de indicadores. Cuando sea necesario introducir cambios en alguno de estos elementos, deberán documentarse y evaluarse antes de incorporarlos a la serie, de manera que sea posible identificar y tratar adecuadamente cualquier ruptura de comparabilidad.

De esta manera, las mediciones realizadas antes de 2026 cumplen una función fundamental como **antecedentes históricos** —metodológicos y de contenido—, y la Resolución 1642 de 2026 aporta el fundamento institucional que ninguna de ellas tuvo. A partir de esta línea base, los cambios observados en las mediciones posteriores de ENUS podrán interpretarse con mayor confianza como cambios en la experiencia de los usuarios y no como consecuencia de modificaciones en la propia operación estadística.

1.8 Referentes internacionales para la medición de la experiencia del usuario en salud

La medición de la experiencia de las personas usuarias se ha desarrollado en diferentes sistemas de salud como una forma de complementar la información proveniente de registros administrativos, indicadores clínicos y evaluaciones institucionales. Estos instrumentos parten de una idea común: algunos aspectos de la calidad de la atención solo pueden conocerse preguntando directamente a las personas que recibieron el servicio.

Para ENUS 2026 se consideran tres referentes internacionales particularmente relevantes: **CAHPS**, desarrollado en Estados Unidos; el marco de **responsiveness** de la Organización Mundial de la Salud; y **PaRIS**, promovido por la OCDE. Estos referentes no constituyen modelos que ENUS 2026 adopte o replique directamente. Su utilidad consiste en aportar antecedentes para definir el concepto de experiencia del usuario, identificar dimensiones relevantes y reconocer buenas prácticas para producir información comparable.

1.8.1 CAHPS: medición estandarizada de la experiencia del paciente

El programa **Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)**, desarrollado por la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos, constituye uno de los referentes más

consolidados para la medición estandarizada de la experiencia de los pacientes. El programa se inició en 1995 y ha desarrollado diferentes instrumentos para evaluar experiencias con planes de salud, profesionales, hospitales y otros servicios de atención (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

Un aspecto central de CAHPS es la distinción entre **experiencia del paciente y satisfacción**. Las encuestas buscan conocer lo que ocurrió durante la atención, por ejemplo, si los profesionales se comunicaron adecuadamente, si el usuario pudo acceder a la atención que necesitaba o si recibió la atención de manera oportuna. Esto se complementa con preguntas de valoración global sobre el proveedor o el servicio (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

Los instrumentos CAHPS utilizan preguntas estandarizadas y producen medidas individuales y medidas compuestas. Estas últimas agrupan varias preguntas relacionadas para representar dimensiones específicas de la experiencia. El programa señala que los elementos centrales de sus cuestionarios se mantienen estandarizados para favorecer la consistencia y comparabilidad de las mediciones (Agency for Healthcare Research and Quality 2024).

Para ENUS 2026, el principal aprendizaje de CAHPS es la necesidad de diferenciar entre **lo que el usuario experimentó durante la atención y la valoración general que hace del servicio**. Esta distinción es fundamental para la definición de las dimensiones e indicadores de experiencia desarrollada en el marco conceptual (3.1).

CAHPS también constituye un referente para la construcción de una serie de largo plazo: la estandarización de un núcleo de preguntas permite comparar resultados entre proveedores y a través del tiempo, sin impedir la incorporación de módulos o preguntas complementarias cuando sean necesarias (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

1.8.2 OMS: capacidad de respuesta de los sistemas de salud

La Organización Mundial de la Salud incorporó el concepto de **responsiveness** como uno de los componentes para evaluar el desempeño de los sistemas de salud en el *World Health Report 2000* (World Health Organization 2000). El concepto se refiere a la manera en que el sistema responde a las expectativas legítimas de las personas en aspectos que no corresponden directamente a los resultados clínicos de la atención.

El marco desarrollado por la OMS agrupa estas expectativas en dos grandes componentes: **respeto por las personas y orientación al usuario**. El primero incluye aspectos como dignidad, confidencialidad y autonomía; el

segundo incorpora elementos como atención oportuna, calidad de las condiciones básicas, posibilidad de elegir proveedor y acceso a redes de apoyo durante la atención (World Health Organization 2000).

Este referente resulta relevante porque amplía la mirada sobre la calidad de los servicios de salud. La experiencia del usuario no se limita a determinar si el tratamiento fue clínicamente adecuado, sino que también incluye la forma en que la persona fue tratada, escuchada, informada y atendida.

Para ENUS 2026, el principal aporte de este marco es la incorporación de dimensiones relacionadas con **trato digno, autonomía, confidencialidad, oportunidad, comunicación y condiciones de atención**, que pueden ser observadas directamente desde la perspectiva de las personas usuarias.

1.8.3 OCDE-PaRIS: experiencias y resultados reportados por los pacientes

El programa **Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS)** de la OCDE representa una etapa más reciente en el desarrollo de mediciones internacionales centradas en la perspectiva de los pacientes. Su objetivo es desarrollar indicadores estandarizados sobre los resultados y las experiencias de atención que son relevantes para las personas (OECD 2025).

El primer ciclo de PaRIS, desarrollado entre 2017 y 2025, reunió información de más de **107.000 pacientes**, atendidos en más de **1.800 centros de atención primaria de 19 países**. La población estudiada estuvo conformada por pacientes de atención primaria de 45 años o más, con especial atención a personas con enfermedades crónicas (OECD 2025).

Una característica importante de PaRIS es la integración de dos tipos de información: los **resultados reportados por los pacientes (PROM)** y las **experiencias reportadas por los pacientes (PREM)**. Esta distinción permite separar lo que ocurrió durante la atención de los resultados que la persona percibe en relación con su salud y bienestar.

Para ENUS 2026, PaRIS aporta principalmente dos elementos. El primero es la importancia de construir indicadores estandarizados que permitan comparar resultados entre territorios y a través del tiempo. El segundo es la conveniencia de distinguir entre **experiencia de atención y resultados de salud reportados por las personas**, evitando que ambos conceptos se mezclen en un mismo indicador.

1.8.4 Elementos comunes de los referentes internacionales

Aunque CAHPS, el marco de *responsiveness* de la OMS y PaRIS tienen objetivos, poblaciones y contextos diferentes, presentan algunos elementos comunes que resultan relevantes para ENUS 2026:

1. **La persona usuaria es una fuente directa de información sobre la calidad de la atención.** Determinados aspectos de la atención no pueden conocerse únicamente mediante registros clínicos o administrativos.
2. **La experiencia debe distinguirse de la satisfacción.** La experiencia se centra principalmente en hechos y situaciones ocurridas durante la atención, mientras que la satisfacción corresponde a una valoración global de esa experiencia.
3. **La experiencia es multidimensional.** Aspectos como comunicación, acceso, oportunidad, trato, participación y coordinación pueden medirse por separado y posteriormente integrarse en un sistema de indicadores.
4. **La estandarización es necesaria para la comparación.** Mantener definiciones, preguntas e indicadores centrales permite interpretar los cambios observados entre mediciones como cambios en la experiencia y no como efectos derivados de modificaciones en el instrumento.
5. **La información debe estar orientada a la mejora.** Estos instrumentos no se limitan a producir un resultado agregado; buscan identificar dimensiones en las que existen diferencias entre proveedores, territorios o grupos de población.

Estos elementos constituyen referentes para la construcción del marco conceptual de ENUS 2026, pero no determinan por sí mismos el diseño de la operación. La definición de las dimensiones, el instrumento, la población objetivo, el mecanismo de captación, el diseño muestral, la ponderación y los procedimientos de estimación se establecen de acuerdo con las características del sistema de salud colombiano y se desarrollan en los capítulos correspondientes de este documento.

Capítulo 2

Objetivo de la ENUS 2026

2.1 Objetivo general

Medir la *satisfacción y la experiencia de las personas usuarias* del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con los servicios de salud utilizados, mediante una operación estadística de recolección continua, para producir información periódica, comparable y estadísticamente sustentada que contribuya al seguimiento, la evaluación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.

2.2 Objetivos específicos

1. *Medir la satisfacción de las personas usuarias* con los servicios de salud utilizados, como valoración general de la atención recibida.
2. *Medir las principales dimensiones de la experiencia del usuario* en la interacción con los servicios de salud, considerando aspectos relacionados con la accesibilidad, oportunidad, trato digno, comunicación y resolutiveidad.
3. *Producir información periódica y oportuna* sobre la satisfacción y la experiencia de las personas usuarias mediante un esquema de recolección continua que permita identificar cambios en los principales indicadores con menor rezago temporal.
4. *Minimizar el potencial sesgo de recuerdo* mediante la recolección de información en proximidad temporal a la utilización del servicio de salud, favoreciendo un reporte más cercano a la experiencia efectivamente vivida por la persona usuaria.

5. *Producir estimaciones para los principales dominios de interés de la operación, incluyendo características sociodemográficas, de afiliación, territoriales y relacionadas con el tipo de servicio utilizado, siempre que los niveles de precisión y confiabilidad estadística permitan sustentar dichas desagregaciones.*
6. *Mantener la comparabilidad temporal de los principales indicadores de satisfacción y experiencia del usuario con las mediciones anteriores, preservando la continuidad conceptual y metodológica cuando resulte pertinente y documentando los cambios que puedan afectar la interpretación de las series.*
7. *Proporcionar información estadística pertinente para el seguimiento de la satisfacción y experiencia de los usuarios, que contribuya a la evaluación y al mejoramiento de las políticas, estrategias y acciones relacionadas con la calidad de los servicios de salud.*

Capítulo 3

Alcance de la operación estadística

El alcance de ENUS 2026 delimita los fenómenos objeto de medición, la población a la que se refieren los resultados, las unidades de observación, la cobertura territorial y temporal, los servicios de salud considerados y los principales dominios de análisis. Estas definiciones establecen el ámbito de interpretación de los resultados y los límites de la información que puede producir la operación estadística.

3.1 Fenómenos objeto de medición

ENUS 2026 mide dos fenómenos relacionados pero conceptualmente diferenciados: la *satisfacción de las personas usuarias con los servicios de salud utilizados* y la *experiencia de las personas usuarias durante su interacción con dichos servicios*.

La *satisfacción* corresponde a la valoración general que realiza la persona usuaria sobre el servicio recibido, expresando su grado de conformidad con la atención proporcionada; es una medida global y retrospectiva, en continuidad con la serie histórica de mediciones del SGSSS (1).

La *experiencia del usuario* comprende, en cambio, hechos concretos ocurridos durante la interacción con los servicios de salud —distintos de esa valoración global—. Los atributos observados en la aplicación de recolección de ENUS 2026 son el acceso (correspondiente a la accesibilidad exigida por el SOGCS), el tiempo de espera (correspondiente a la oportunidad exigida por el SOGCS, 1), la humanización del trato y la entrega de medicamentos.

Ambos fenómenos se miden de manera complementaria: la satisfacción proporciona una valoración global de la atención recibida, mientras que los atributos de experiencia permiten caracterizar los aspectos concretos de la interacción que contribuyen a dicha valoración. Este enfoque combinado — valoración global junto con hechos concretos— sigue el mismo patrón que utilizan los referentes internacionales identificados en los antecedentes de este documento, en particular CAHPS (1).

ENUS 2026 mide percepciones y valoraciones reportadas directamente por las personas usuarias. Por tanto, sus resultados no constituyen mediciones directas de resultados clínicos, desenlaces en salud, efectividad de los tratamientos ni de la calidad técnica de la atención, salvo en aquellos aspectos que sean explícitamente operacionalizados mediante el instrumento.

3.2 Población objetivo

La población objetivo de ENUS 2026 está constituida por las *personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que hayan utilizado, durante alguno de los trimestres del año de referencia, al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de medición de la encuesta*.

La población comprende las personas afiliadas a los regímenes considerados por el SGSSS, independientemente de su sexo, edad, territorio de residencia u otras características sociodemográficas. La utilización de un servicio de salud durante el año de referencia constituye la condición que vincula a la persona con el fenómeno objeto de medición, dado que las preguntas de satisfacción y experiencia se refieren a una atención o servicio efectivamente utilizado.

Para efectos de la operación estadística, la identificación de las personas elegibles se realiza de manera continua durante el año, tomando como periodo de referencia para la utilización del servicio cada trimestre calendario. En consecuencia, para cada trimestre se consideran las personas que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1. *Afiliación al SGSSS*: encontrarse afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo correspondiente a la utilización del servicio.
2. *Utilización de servicios de salud*: haber utilizado al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de ENUS 2026.
3. *Periodo de referencia*: que la utilización del servicio haya ocurrido durante el trimestre correspondiente.

Los cuatro trimestres conforman el periodo anual de referencia de la operación. De esta manera, la recolección se desarrolla de forma continua a lo largo del año, mientras que la producción principal de resultados corresponde al *año de referencia*, integrando la información recolectada durante sus respectivos periodos trimestrales.

La identificación y selección de las personas pertenecientes a la población objetivo se realizará mediante los mecanismos de captación y verificación definidos para la operación estadística. Estos mecanismos podrán apoyarse en diferentes fuentes de información y herramientas tecnológicas y podrán modificarse durante el ciclo de vida de la encuesta sin alterar la definición conceptual de la población objetivo.

La base de usuarios habilitados para acceder a *ClicSalud* y diligenciar el cuestionario se actualiza cada cuatro meses a lo largo del año. El propósito de esta actualización periódica es incorporar a la base a los usuarios que, por haberse afiliado al SGSSS o haber utilizado un servicio de salud con posterioridad al corte anterior, aún no se encontraban habilitados para participar. De esta manera, la base de usuarios se mantiene alineada, a lo largo del año, con la definición continua de la población objetivo establecida en esta sección, aunque la habilitación efectiva de un usuario recientemente elegible queda sujeta al ciclo de actualización vigente y no ocurre en tiempo real (4).

La población efectivamente observada estará constituida por las personas de la población objetivo que sean captadas o seleccionadas mediante los procedimientos establecidos y que proporcionen información válida para la estimación de los indicadores.

La definición de la población objetivo, los criterios de elegibilidad y los procedimientos de selección deberán garantizar que la información recolectada durante los cuatro trimestres permita producir estimaciones anuales representativas de la población objetivo del año correspondiente.

3.3 Unidad de observación

La unidad de observación de ENUS 2026 es la persona afiliada al SGSSS que haya utilizado un servicio de salud incluido en el ámbito de la operación durante el periodo de referencia.

La información recolectada corresponde a la satisfacción y experiencia reportadas por la persona respecto del servicio utilizado. Las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y demás actores relacionados con la prestación de los servicios no constituyen unidades de observación.

3.4 Cobertura territorial

ENUS 2026 tendrá cobertura nacional, con una distribución de la muestra que garantizará una cuota mínima de participación para cada uno de los 33 departamentos (32 departamentos y Bogotá D.C.) definidos en la operación.

El departamento constituye el nivel territorial mínimo previsto para la producción de resultados, condicionado a que la meta departamental se cumpla efectivamente al cierre del periodo de recolección (4); los departamentos se agregan, para efectos de reporte, en seis regiones bajo el esquema estándar DANE/ENDS. La participación efectiva de los usuarios podrá permitir desagregaciones territoriales adicionales dentro de cada departamento, siempre que se alcance un número suficiente de observaciones y condiciones adecuadas de calidad estadística para su interpretación.

3.5 Cobertura temporal y periodo de referencia

ENUS 2026 adopta un esquema de *recolección continua durante el año*, organizado en cuatro periodos trimestrales de referencia.

El periodo de referencia corresponde al *trimestre en el que la persona utilizó el servicio de salud* objeto de la medición. La satisfacción y experiencia reportadas se refieren a dicha utilización.

La recolección continua permite aproximar el momento de la encuesta al momento de utilización del servicio, reduciendo el potencial efecto del recuerdo retrospectivo.

Los resultados de ENUS 2026 se producirán con *periodicidad anual*, integrando la información recolectada durante los cuatro trimestres del año de referencia.

3.6 Servicios de salud objeto de medición

ENUS 2026 mide la satisfacción y experiencia de las personas usuarias frente a los *servicios de salud incluidos en el ámbito de la operación*.

La medición se realiza de acuerdo con el tipo de servicio utilizado, de manera que el instrumento permita recoger las características específicas de la interacción de la persona con el sistema de salud.

La clasificación de los servicios considerados y la asignación de las preguntas correspondientes hacen parte de la estructura del instrumento de recolección.

3.7 Dominios de análisis

ENUS 2026 contempla la producción de resultados para el *total nacional y para las regiones definidas en la operación*, de acuerdo con las cuotas mínimas de participación establecidas para cada una.

La información recolectada permitirá explorar desagregaciones adicionales según características de las personas usuarias, de su afiliación y del servicio utilizado. La disponibilidad de estas desagregaciones dependerá de la participación efectiva alcanzada en las categorías correspondientes y de las condiciones de calidad requeridas para su presentación e interpretación.

Los principales resultados corresponderán a indicadores de *satisfacción y experiencia del usuario*, tanto de manera general como para las dimensiones consideradas en el instrumento, de acuerdo con el tipo de servicio evaluado.

3.8 Límites del alcance

El alcance de ENUS 2026 está determinado por la población objetivo, los servicios de salud incluidos, el instrumento de recolección y el diseño de la operación estadística.

Los resultados corresponden a la *satisfacción y experiencia reportadas por las personas participantes* respecto de los servicios de salud utilizados. No constituyen una medición integral del desempeño del SGSSS ni sustituyen otras fuentes de información requeridas para evaluar resultados clínicos, desenlaces en salud, efectividad de tratamientos o calidad técnica de la atención.

La cobertura mínima por región se establece mediante cuotas de participación. Las desagregaciones adicionales estarán condicionadas por la participación efectiva alcanzada y por criterios de suficiencia y calidad de la información.

La Resolución 1642 de 2026 habilita la desagregación de los resultados de ENUS por EPS, institución prestadora, departamento, distrito y municipio, entre otros niveles (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Esta habilitación normativa no debe confundirse con una garantía de precisión estadística en esos niveles: el diseño muestral de la operación solo asegura la precisión nominal a nivel de región; las desagregaciones por EPS, institución prestadora o municipio dependerán de la participación efectivamente alcanzada en cada categoría y podrán no ser publicables si no cumplen los criterios de suficiencia y calidad establecidos.

Capítulo 3. Alcance de la operación estadística

Dado el carácter no probabilístico de la operación, las desagregaciones y resultados deberán interpretarse de acuerdo con el alcance del diseño de selección y con las condiciones bajo las cuales se obtuvo la información.

Capítulo 4

Diseño muestral

El diseño muestral de la ENUS 2026 establece el marco del cual se seleccionan las personas participantes, las probabilidades con que son invitadas y asignadas a cada parte del cuestionario, y las metas de respuesta que orientan el seguimiento de la operación por departamento y grupo poblacional.

Decisión metodológica adoptada (septiembre de 2026). La Resolución 1642 de 2026 dispone que el diseño metodológico de la ENUS «garantizará la representatividad estadística de los resultados mediante un marco muestral probabilístico que asegure el control sobre la generación de la información, la comparabilidad de los resultados en el tiempo y la reducción de sesgos por autoselección de los respondientes» (art. 9) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). En cumplimiento de esa disposición, la ENUS 2026 adopta un **diseño probabilístico por invitación a la totalidad del marco**, que reemplaza el esquema de muestreo no probabilístico por cuotas documentado en versiones anteriores de este documento. El diseño tiene tres componentes:

1. **Marco muestral.** Las personas afiliadas al SGSSS registradas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) que cuentan con una atención en salud registrada en el periodo de referencia, en correspondencia con la población objetivo (3.2).
2. **Invitación a todo el marco.** El Ministerio invita a participar a todas las personas del marco. La probabilidad de invitación es, por tanto, igual a 1 para toda la población objetivo cubierta por el marco. Las personas invitadas que no ingresan al aplicativo o no completan el cuestionario constituyen **no respuesta**, que se ajusta posteriormente mediante calibración con la BDUA.

3. **Selección probabilística para la Parte 3.** Entre las personas que completan la Parte 2 en su primer ingreso, un sorteo Bernoulli con probabilidad fija $\pi = 0,8$ determina quién responde un módulo específico, y dentro del prestador elegido el módulo se asigna al azar (4.2).

Las metas por departamento y por celda de régimen, sexo, grupo de edad y zona que se calculan en este capítulo se conservan como **metas de respuesta**: fijan el número de respuestas que se espera obtener en cada grupo y sirven para monitorear la operación y reforzar la invitación donde la respuesta sea insuficiente. No restringen la participación ni constituyen probabilidades de selección.

El diseño se estructura en dos niveles. Primero, se determina una meta de respuesta para cada **departamento**, de manera que la operación disponga de un número suficiente de observaciones para producir resultados a ese nivel —condicionado, como se precisa más adelante (4.3.10), a que la meta departamental se cumpla efectivamente al cierre del periodo de recolección—. Segundo, la meta de cada departamento se distribuye entre las celdas definidas por régimen de afiliación, sexo, grupo de edad y zona, utilizando la estructura poblacional de referencia y estableciendo mínimos para las celdas de menor tamaño. La región (agrupación estándar DANE/ENDS de los 32 departamentos y Bogotá D.C.) se conserva como nivel de agregación para el reporte de resultados.

A partir de esta estructura, el presente capítulo desarrolla el marco y la invitación, el mecanismo de asignación de la Parte 3, la determinación de las metas de respuesta, la diferenciación entre los conceptos de meta de respuesta, estrato, dominio y variable de calibración y, finalmente, las implicaciones del diseño para el alcance inferencial de los resultados.

4.1 Marco muestral, invitación y no respuesta

4.1.1 Marco muestral

El marco muestral está conformado por las personas registradas en la BDUA con afiliación activa que tienen al menos una atención en salud registrada en el periodo de referencia. Cada registro del marco identifica a la persona, las variables de afiliación y demográficas que se utilizan para las metas y la calibración (departamento, régimen, sexo, edad y zona) y la atención que origina la invitación.

La cobertura del marco depende de la oportunidad y completitud del registro de atenciones: una atención no reportada, o reportada con rezago, deja a la persona por fuera de la invitación del periodo correspondiente. Esta

condición constituye un error de cobertura y se documenta en el capítulo de limitaciones.

Pendiente de definición: la fuente del registro de atenciones (por ejemplo, RIPS o factura electrónica de venta), su rezago de disponibilidad y la frecuencia con que se conforma el marco y se envían las invitaciones.

4.1.2 Invitación

Decisión metodológica adoptada. Toda persona del marco queda **invitada automáticamente** a participar, y la invitación se le comunica mediante un **aviso individual** (mensaje de texto, correo electrónico o notificación del aplicativo), enviado con los datos de contacto disponibles en la BDUA y en las bases de información del Ministerio. El aviso es indispensable: una persona que queda habilitada en el marco pero no se entera de que puede participar no ha sido invitada en sentido efectivo, y su participación dependería de la autoselección que el artículo 9 de la Resolución 1642 de 2026 exige reducir.

El aviso individual se complementa con la promoción prevista en la Resolución; en particular, las EPS, IPS y gestores farmacéuticos están obligados a promover activamente el uso del aplicativo en sus puntos de atención mediante carteles, mensajes de texto y notificaciones push (art. 12, num. 1) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Dado que la probabilidad de invitación es igual a 1, el peso de diseño asociado a la invitación es:

$$d_i^{\text{inv}} = \frac{1}{\pi_i^{\text{inv}}} = 1.$$

El conjunto de personas del marco constituye el **registro de personas invitadas** del periodo. Las respuestas se vinculan a ese registro mediante el documento de identidad con el que la persona se identifica en el aplicativo, lo que permite calcular las tasas de respuesta y distinguir las respuestas de personas invitadas de las de personas que ingresan al aplicativo sin pertenecer al marco del periodo. Cuando se disponga de la fecha y el canal de cada aviso, estos datos permiten distinguir además la falta de contacto del rechazo a participar.

Pendiente de definición:

- el responsable del envío del aviso de invitación;
- la completitud de los datos de contacto en la BDUA y en las bases del Ministerio, y el tratamiento de las personas del marco sin datos de contacto, que no pueden recibir el aviso y constituyen un error de cobertura de la invitación;

- la regla para personas con varias atenciones en el periodo (por ejemplo, una invitación por persona y prestador en cada trimestre, en concordancia con el bloqueo anual por prestador);
- el tratamiento de las respuestas de personas que ingresan al aplicativo sin invitación.

4.1.3 No respuesta

La participación de las personas invitadas es voluntaria. La probabilidad de que una persona invitada responda no es conocida, por lo que la no respuesta constituye la principal fuente de sesgo potencial del diseño: si quienes responden difieren de quienes no responden en su satisfacción o experiencia, los resultados sin ajuste reflejarían esa diferencia.

El tratamiento de la no respuesta se realiza mediante calibración de los pesos con los totales de la BDUA (ver capítulo de ponderación y calibración). La calibración corrige las diferencias en las variables auxiliares utilizadas, pero no garantiza la corrección de diferencias en otras características asociadas con la respuesta. Por esta razón, la **tasa de respuesta** — número de personas que completan la Parte 2 sobre el número de personas invitadas— se adopta como indicador de calidad central de la operación y debe calcularse y publicarse por departamento, régimen, sexo y grupo de edad.

De manera general, la operación comprende la siguiente secuencia:

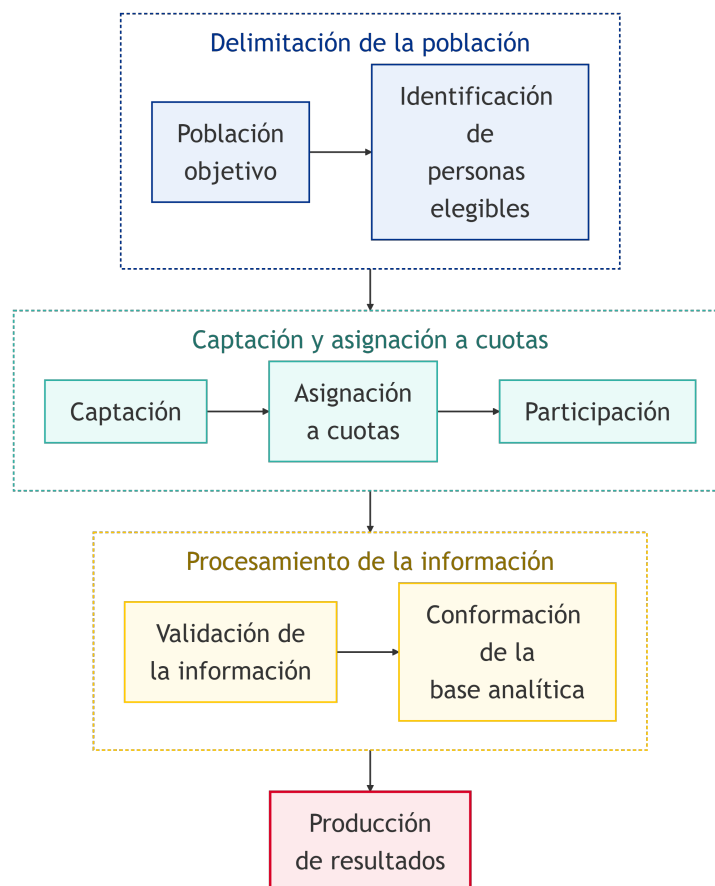


Figura 4.1: Secuencia operativa de la ENUS 2026, desde la población objetivo hasta la producción de resultados.

Pendiente de actualización visual. La figura corresponde al esquema anterior de captación por cuotas y debe actualizarse para incluir el marco muestral, la invitación y el registro de no respuesta.

4.2 Mecanismo de asignación de la Parte 3

Esta sección documenta el mecanismo que opera sobre las personas invitadas que ingresan al aplicativo: qué determina **si responden la Parte 3** del cuestionario y **cuál módulo específico** les corresponde. Este mecanismo es independiente de las metas de respuesta: el sorteo y la asignación no alteran las metas por celda, y la celda a la que pertenece la persona no

condiciona el resultado del sorteo ni la asignación de módulo.

4.2.1 Estructura de la encuesta en tres partes

El formulario de *ClicSalud* se estructura en tres partes secuenciales:

- **Parte 1 (datos administrativos).** Se completa automáticamente a partir de BDUa en cada ingreso: identificación del usuario y datos demográficos que definen su celda de meta de respuesta.
- **Parte 2 (preguntas comunes).** Preguntas de respuesta directa del usuario sobre experiencia general de atención y servicio. Todas las personas que avanzan más allá de Parte 1 la responden; en ingresos posteriores al primero, ya completada, no se repite.
- **Parte 3 (módulo específico).** Diez o más preguntas adicionales sobre las características particulares de un prestador. Solo se responde si el mecanismo descrito a continuación lo determina.

4.2.2 Primer ingreso: sorteo, elección y asignación

Al finalizar Parte 2 en su primer ingreso, la persona queda sujeta a un sorteo Bernoulli $u \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ con corte $\pi = 0,8$:

$$\text{Accede a Parte 3} = \begin{cases} \text{Sí,} & \text{si } u \leq 0,8 \\ \text{No,} & \text{si } u > 0,8 \end{cases}$$

Si el sorteo es negativo ($u > 0,8$), la encuesta finaliza sin Parte 3. Si es positivo ($u \leq 0,8$), la persona **elige** cuál prestador desea evaluar entre los que tiene habilitados en BDUa (registro de uso de EPS, IPS o gestor farmacéutico) y que no estén bloqueados (ver más adelante). Elegido el prestador, el sistema le asigna **al azar** uno de los módulos disponibles para ese prestador, con probabilidad $P(\text{módulo} \mid \text{prestador}) = 1/n_{\text{prestador}}$:

Prestador elegido	Módulos disponibles	$P(\text{módulo})$
EPS	3	1/3
IPS	4	1/4
Gestor farmacéutico	1	1

El módulo asignado **no depende del servicio efectivamente recibido**: es una asignación aleatoria dentro del prestador elegido. Esto introduce un sesgo de disponibilidad —el módulo puede no coincidir con la experiencia real de la persona— que se retoma como limitación del diseño más adelante en el documento.

4.2.3 Ingresos posteriores

En un ingreso posterior al primero, el prestador evaluado en la ocasión anterior queda **bloqueado por un año calendario**: la persona solo puede elegir entre los prestadores habilitados que aún no haya evaluado o cuyo bloqueo ya haya expirado. En estos ingresos, Parte 1 se actualiza con la información más reciente de BDUA, Parte 2 no se repite (ya fue completada) y **no se ejecuta el sorteo Bernoulli**: la persona accede directamente a la elección de prestador. Una misma persona puede así generar hasta tres registros completos (uno por prestador), cada uno con su propia Parte 1 actualizada y su propio módulo asignado.

4.2.4 Probabilidades y pesos de diseño de la Parte 3

Las probabilidades de la Parte 3 son conocidas y se registran para cada persona. Condicionado al prestador elegido, la probabilidad de responder el módulo j y el peso de diseño correspondiente son:

Cuadro 4.1: Probabilidades y pesos de diseño de la Parte 3, condicionados al prestador elegido, ENUS 2026.

Ingreso	Probabilidad de responder el módulo j	Peso de diseño d_i
Primer ingreso	$\pi_{ij} = 0,8 \times \frac{1}{n_{\text{prestador}}}$	$\frac{n_{\text{prestador}}}{0,8}$
Ingresos posteriores	$\pi_{ij} = \frac{1}{n_{\text{prestador}}}$	$n_{\text{prestador}}$

Para las Partes 1 y 2 el peso de diseño es $d_i^{\text{inv}} = 1$ (4.1). Todos los pesos de diseño se calibran posteriormente con la BDUA para ajustar por no respuesta.

La elección del prestador corresponde a la persona y no a un mecanismo aleatorio. En consecuencia, los pesos de la Parte 3 son válidos **condicionados al prestador elegido**: los indicadores de un módulo representan a las personas que respondieron la Parte 2 y eligieron evaluar ese tipo de prestador, no a la totalidad de usuarios de ese prestador. Esta condición se retoma como limitación del diseño.

4.2.5 Módulos de Parte 3

ENUS 2026 define ocho módulos de Parte 3, cuyo contenido proviene de la especificación del instrumento por módulo (00_Cuestionario/ENUS_Formato_por_Modulos.xlsx):

Cuadro 4.2: Módulos de Parte 3 asignables por prestador, ENUS 2026.

Prestador	Módulo	Enfoque
EPS	Módulo 1	Barreras de acceso (contenido original, para población sin uso de servicios)
EPS	Módulo 2	Deberes y derechos
EPS	Módulo 3	Ambulatorio
IPS	Módulo 1	Ambulatorio
IPS	Módulo 2	Urgencias
IPS	Módulo 3	Internación
IPS	Módulo 4	Quirúrgico
Gestor farmacéutico	Módulo 1	Medicamentos

Pendiente de definición. El contenido original del módulo EPS 1 está dirigido a población que *no* ha utilizado servicios de salud (barreras de acceso), lo cual es inconsistente con el criterio de elegibilidad de la operación, que exige un registro BDUA de uso efectivo de un servicio (3.2). Mientras esta inconsistencia no se resuelva, el módulo se conserva como una de las tres opciones asignables al azar dentro de EPS.

4.2.6 Diferenciación frente a las metas de respuesta

El mecanismo de sorteo, elección y asignación descrito en esta sección es distinto de las metas de respuesta (4): las metas fijan cuántas respuestas se espera obtener en cada grupo; el sorteo determina si una persona que respondió la Parte 2 responde la Parte 3; la elección de prestador y la asignación aleatoria de módulo determinan qué contenido específico responde. Ninguno de estos elementos constituye un estrato, y ninguno modifica las metas de respuesta por celda.

4.3 Determinación del tamaño de muestra

El tamaño objetivo de la operación se determina a partir de una precisión nominal definida para los principales indicadores. Para este propósito se utiliza como población de referencia la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), registrada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con corte a marzo de 2026, correspondiente a $N = 50\,168\,746$ personas.

La BDUA se utiliza como fuente de referencia para establecer los parámetros poblacionales y distribuir las metas de respuesta. Dado que se invita a la totalidad del marco (4.1), el tamaño calculado en esta sección no determina a quién se invita: fija el **número de respuestas** que se busca obtener para alcanzar la precisión nominal definida.

El cálculo parte de un escenario de muestreo aleatorio simple, utilizado como *referencia para establecer una meta nominal de respuesta*. Sobre este resultado se incorpora un efecto de diseño y, cuando corresponde, una corrección por población finita. Finalmente, se aplica un factor operativo para determinar la meta de respuesta frente a pérdidas esperadas durante la operación.

4.3.1 Cálculo de referencia

Para la estimación de una proporción, el tamaño de muestra bajo muestreo aleatorio simple se expresa como:

$$n_{MAS} = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{ME^2},$$

donde P es la proporción de referencia, $Z_{1-\alpha/2}$ corresponde al cuantil de la distribución normal asociado al nivel de confianza y ME es el margen de error absoluto. Esta formulación corresponde al cálculo convencional del tamaño de muestra para proporciones bajo muestreo aleatorio simple (Cochran 1977; Lohr 2021).

En la ENUS 2026 se adopta $P = 0,50$, valor que maximiza la varianza de una proporción y, por tanto, produce un tamaño de referencia conservador cuando no se dispone de una proporción previa.

El margen de error absoluto se obtiene a partir de la longitud total del intervalo de confianza definida para el diseño:

$$ME = Z_{1-\alpha/2} \left(\frac{L}{2} \right),$$

donde L representa la longitud total del intervalo.

Dado que el diseño utiliza un margen de error relativo, este se obtiene mediante:

$$MER = \frac{ME}{P}.$$

Con un nivel de confianza del 95 %, $P = 0,50$ y una longitud total del intervalo de 0,04, se obtiene:

$$ME = 1,96 \times 0,02 = 0,0392$$

y, por tanto,

$$MER = \frac{0,0392}{0,50} = 0,0784,$$

equivalente a un margen de error relativo del **7,84 %**.

El tamaño de referencia resultante es aproximadamente:

$$n_{MAS} \approx 625.$$

4.3.2 Ajuste por efecto de diseño

El tamaño de referencia se ajusta mediante un efecto de diseño ($DEFF$) de 1,5:

$$n_{DEFF} = n_{MAS} \times DEFF.$$

El efecto de diseño expresa la relación entre la varianza de un estimador bajo un determinado esquema de diseño y la varianza que tendría bajo muestreo aleatorio simple con igual tamaño de muestra. Su utilización permite incorporar, de manera aproximada, pérdidas de eficiencia asociadas con la estructura del diseño.

Para la ENUS 2026:

$$n_{DEFF} = 625 \times 1,5 \approx 938.$$

Este ajuste debe interpretarse como parte del procedimiento utilizado para establecer el tamaño objetivo y no como una estimación empírica de la varianza del diseño de la ENUS.

4.3.3 Corrección por población finita

Cuando el tamaño de la población del dominio no es suficientemente grande respecto del tamaño de muestra requerido, se incorpora la corrección por población finita:

$$n_{ajustado} = \frac{n_{DEFF}}{1 + \frac{n_{DEFF}}{N}}.$$

La corrección por población finita reduce el tamaño requerido cuando la fracción de muestreo deja de ser despreciable. Para poblaciones grandes respecto del tamaño de muestra, su efecto es prácticamente nulo (Cochran 1977).

En la ENUS 2026, la corrección se aplica al nivel en el que efectivamente se fija la meta —la región (4.3)—, no a una combinación región × régimen: el régimen se distribuye después, dentro del presupuesto ya fijado para la región. Para la región de menor tamaño poblacional, Orinoquía-Amazonía, con $N \approx 1\,428\,022$, el tamaño se reduce de manera prácticamente nula, de aproximadamente 938 a 937.

4.3.4 Ajuste operativo y meta de respuesta

Finalmente, el tamaño ajustado se incrementa mediante un factor operativo $f = 1,4$, destinado a compensar anticipadamente pérdidas asociadas con no respuesta, imposibilidad de contacto y registros que no superen los criterios de validación establecidos para la operación:

$$n_{meta} = n_{ajustado} \times f.$$

Para las seis regiones, este procedimiento conduce a una meta de respuesta del orden de **1 311 a 1 313 participaciones por región**.

Este resultado debe leerse como el *número de respuestas* que se busca obtener para alcanzar la precisión nominal. La precisión efectivamente alcanzada se estima a partir de los pesos calibrados y de las réplicas (ver capítulo de precisión e incertidumbre), y depende del número de respuestas obtenidas y de la variabilidad de los pesos después del ajuste por no respuesta.

Pendiente de definición. El factor operativo $f = 1,4$ se definió para el esquema anterior de captación por cuotas. Bajo el diseño por invitación a todo el marco, debe revisarse su justificación: la no respuesta a la invitación ya no reduce el número de respuestas frente a la meta, pero sí lo hacen los registros que no superan la validación.

4.3.5 Parámetros adoptados

El procedimiento descrito proporciona una **referencia cuantitativa para establecer las metas de respuesta**. Aunque el diseño de la ENUS 2026 es

probabilístico en la invitación y en la asignación de la Parte 3, la respuesta a la invitación es voluntaria; por tanto, los valores obtenidos no garantizan por sí mismos el margen de error nominal. La precisión alcanzada debe estimarse con el diseño efectivamente implementado, y su interpretación debe considerar el posible sesgo de no respuesta (Baker et al. 2013).

Cuadro 4.3: Parámetros adoptados para la determinación del tamaño de muestra objetivo, ENUS 2026.

Parámetro	Símbolo	Valor
Proporción de referencia	P	0,50
Nivel de confianza	$1 - \alpha$	95 %
Longitud total del intervalo	L	0,04
Margen de error absoluto	ME	0,0392
Margen de error relativo	MER	7,84 %
Efecto de diseño	$DEFF$	1,5
Factor operativo	f	1,4

La evaluación de la composición alcanzada, así como los procedimientos de ponderación y calibración utilizados posteriormente, se desarrollan en las secciones correspondientes.

4.3.6 Tamaño adoptado: asignación por departamento

Decisión metodológica adoptada. El tamaño objetivo se establece en función del departamento, y no de la región, como nivel de desagregación territorial previsto para la producción de resultados. La razón de este cambio es que Parte 1 (datos administrativos) y Parte 2 (preguntas comunes) son obligatorias para la totalidad de las personas que responden, con independencia del resultado del sorteo Bernoulli y de la asignación de módulo de Parte 3 (4.2); ampliar la meta de respuesta al nivel departamental aprovecha esa obligatoriedad para que los indicadores construidos con Parte 1-2 puedan, sujeto a lo indicado en 4.3.10, desagregarse por departamento y no solo por región.

Los 32 departamentos del país y Bogotá D.C. (33 dominios en total) se agrupan, para efectos de reporte, en el esquema estándar de regionalización DANE/ENDS de seis regiones:

Cuadro 4.4: Composición departamental de las seis regiones, utilizadas como agrupación de reporte, ENUS 2026.

Región	Departamentos que la conforman
Bogotá	Bogotá D.C.
Central	Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá
Oriental	Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta
Caribe	Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés
Pacífica	Cauca, Chocó, Nariño, Valle
Orinoquía-Amazonía	Arauca, Casanare, Vichada, Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés

El cálculo realizado para el total nacional constituye únicamente una referencia para una estimación agregada del país. Si se utilizara exclusivamente ese valor, la muestra sería suficiente para establecer una meta de respuesta nacional, pero no para reproducir ese mismo criterio de tamaño en cada uno de los 33 departamentos.

Por esta razón, el tamaño objetivo nacional se obtiene mediante la suma de las metas departamentales:

$$n_{\text{nacional}} = \sum_{d=1}^{33} n_d.$$

Con los tamaños adoptados para los 33 departamentos, se obtiene una meta nacional de **43.176 participaciones** (43.159 tras el redondeo del reparto por celda que se describe en la siguiente sección, con diferencias de -0,2 a -0,8 por departamento atribuibles al mismo procedimiento de redondeo ya documentado para el reparto por celda). El detalle completo de las metas departamentales se presenta a continuación:

Cuadro 4.5: Meta de respuesta por departamento (BDUA marzo de 2026, DEFF=1,5, factor operativo=1,4), ENUS 2026. Fuente: 03_Encuesta/01_Tamaño_Muestra/Output/02_tamanos_muestra_deff_1.5.xlsx, hoja 3_Departamento.

Región	Departamento	N (BDUA)	Meta (n_{efectivo})
Bogotá	Bogotá D.C.	7.780.253	1.313
Caribe	Atlántico	2.806.306	1.313

Región	Departamento	N (BDUA)	Meta (n_{efectivo})
Caribe	Bolívar	2.345.340	1.313
Caribe	Cesar	1.284.077	1.312
Caribe	Córdoba	1.670.770	1.312
Caribe	La Guajira	1.151.490	1.312
Caribe	Magdalena	1.402.034	1.312
Caribe	San Andrés	61.282	1.294
Caribe	Sucre	944.956	1.312
Central	Antioquia	6.959.952	1.313
Central	Caldas	911.331	1.312
Central	Caquetá	411.841	1.310
Central	Huila	1.184.153	1.312
Central	Quindío	569.685	1.310
Central	Risaralda	1.076.349	1.312
Central	Tolima	1.300.917	1.312
Oriental	Boyacá	1.171.268	1.312
Oriental	Cundinamarca	2.765.132	1.313
Oriental	Meta	1.080.475	1.312
Oriental	Norte de Santander	1.746.638	1.312
Oriental	Santander	2.270.133	1.313
Orinoquía-Amazonía	Amazonas	76.629	1.298
Orinoquía-Amazonía	Arauca	319.492	1.309
Orinoquía-Amazonía	Casanare	434.332	1.310
Orinoquía-Amazonía	Guainía	54.596	1.291
Orinoquía-Amazonía	Guaviare	85.937	1.299
Orinoquía-Amazonía	Putumayo	332.640	1.309
Orinoquía-Amazonía	Vaupés	34.307	1.278
Orinoquía-Amazonía	Vichada	90.089	1.299
Pacífica	Cauca	1.329.172	1.312
Pacífica	Chocó	441.422	1.310
Pacífica	Nariño	1.447.016	1.312
Pacífica	Valle	4.628.732	1.313
Total nacional	33 departamentos	50.168.746	43.176

El régimen de afiliación no se utiliza como un nivel adicional e independiente para determinar el tamaño total. En consecuencia, no se asigna una meta independiente a cada combinación departamento × régimen. Hacerlo implicaría establecer 66 metas independientes y elevaría sustancialmente el tamaño total de la operación.

En su lugar, el tamaño correspondiente a cada departamento constituye una meta fija de respuesta que posteriormente se distribuye entre los dos regímenes de afiliación de acuerdo con su participación poblacional en la BDUA. El régimen, por tanto, interviene en la **composición de la meta departamental**, pero no genera un tamaño adicional que deba sumarse al tamaño departamental.

Esta decisión permite mantener el objetivo de participación establecido para cada departamento y, simultáneamente, reproducir dentro de cada uno de ellos la estructura poblacional de los regímenes de afiliación. Las metas obtenidas para las combinaciones departamento × régimen constituyen, por tanto, componentes del tamaño departamental y no dominios independientes de tamaño.

4.3.7 Distribución de la meta por celdas

Una vez definidos los tamaños objetivo departamentales, cada departamento se desagrega en las celdas que conforman la estructura de metas de respuesta. Las celdas resultan del cruce de cuatro variables:

- régimen de afiliación: contributivo y subsidiado;
- sexo: femenino y masculino;
- grupo de edad: 00–09, 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 y 60 años o más;
- zona: urbana y rural.

Esta estructura genera **56 celdas por departamento** y **1.848 celdas para el conjunto nacional** (33 departamentos × 56 celdas).

La asignación inicial de cada celda se realiza de manera proporcional a su peso poblacional dentro del departamento, utilizando como referencia la distribución observada en la BDUA con corte a marzo de 2026:

$$n_c = n_d \frac{N_c}{N_d},$$

donde n_c corresponde al tamaño inicial de la celda c , n_d al tamaño objetivo del departamento al que pertenece, N_c al número de personas de la celda en la BDUA y N_d al total de personas del departamento.

Sobre esta asignación proporcional se establece un **mínimo de 10 participaciones por celda**, con el propósito de evitar que las categorías de menor tamaño poblacional queden sin meta de respuesta:

$$n_c^* = \max \left\{ n_d \frac{N_c}{N_d}, 10 \right\}.$$

La aplicación del mínimo puede generar una suma superior o inferior al tamaño departamental inicialmente distribuido. Por esta razón, la asignación definitiva incorpora un procedimiento de ajuste que conserva el tamaño total establecido para cada departamento y mantiene, en la medida permitida por las restricciones de mínimo, la relación proporcional derivada de la estructura poblacional.

Una vez obtenidas las asignaciones enteras, el ajuste final se realiza mediante el **método del resto mayor**. Para ello, se asigna inicialmente la parte entera de cada meta y las unidades restantes se distribuyen entre las celdas con las mayores partes fraccionarias, hasta completar exactamente el tamaño departamental establecido.

El procedimiento produce una estructura nacional de 1.848 metas de respuesta por celda. De ellas, 40 corresponden al mínimo de 10 participaciones —concentradas en los departamentos de menor población, como Vaupés, Guainía y San Andrés—, mientras que la meta de mayor tamaño alcanza 72 respuestas. El establecimiento de un mínimo implica una sobrerrepresentación deliberada de las celdas demográficamente menos numerosas respecto de su peso poblacional. Esta decisión responde a la necesidad operativa de conservar participación en los grupos de menor tamaño y será considerada posteriormente en la construcción y calibración de los pesos analíticos.

La matriz completa de las 1.848 celdas se generó ejecutando, a nivel departamental, el mismo procedimiento ya adoptado a nivel región (proporcional a población + mínimo garantizado + resto mayor), y se encuentra en 03_Encuesta/01_Tamaño_Muestra/Output/04_asignacion_sexo_edad10_departamento_regimen.xlsx. El **Anexo E — Matriz de cuotas (4)**, organizado hasta ahora por región, queda pendiente de regenerar a partir de este nuevo archivo para reflejar la estructura departamental.

4.3.8 Resultado agregado por región y régimen

Aunque la meta se fija por departamento, la agregación de los departamentos que conforman cada región permite obtener, con fines de reporte, la distribución de la meta regional entre los dos regímenes de afiliación:

Cuadro 4.6: Distribución de la meta de respuesta por región (agregación de departamentos) y régimen de afiliación, ENUS 2026.

Región	Contributivo	Subsidiado	Total región
Bogotá	855	458	1.313
Caribe	4.068	6.406	10.474
Central	4.212	4.965	9.177
Oriental	3.038	3.521	6.559
Orinoquía-Amazonía	3.405	6.986	10.391
Pacífica	1.921	3.324	5.245
Total nacional	17.499	25.660	43.159

La distribución muestra que la composición por régimen varía entre regiones de acuerdo con la estructura poblacional de referencia. No obstante, las metas de ambos regímenes se encuentran contenidas dentro del tamaño total definido para cada región. El detalle por cada uno de los 33 departamentos se presenta en 4.5 y en el archivo fuente de la matriz de celdas (4.3).

4.3.9 Composición agregada de las metas

La agregación de las metas a nivel nacional produce la siguiente composición según sexo:

Cuadro 4.7: Composición agregada de la meta nacional por sexo, ENUS 2026.

Sexo	<i>n</i>	%
Femenino	21.760	50,4 %
Masculino	21.399	49,6 %

Por grupo de edad:

Cuadro 4.8: Composición agregada de la meta nacional por grupo de edad, ENUS 2026.

Grupo de edad	<i>n</i>	%
00–09	5.952	13,8 %
10–19	6.686	15,5 %
20–29	6.532	15,1 %

Grupo de edad	<i>n</i>	%
30–39	6.416	14,9 %
40–49	5.814	13,5 %
50–59	5.246	12,2 %
60 o más	6.513	15,1 %

Y por zona:

Cuadro 4.9: Composición agregada de la meta nacional por zona, ENUS 2026.

Zona	<i>n</i>	%
Urbana	25.751	59,7 %
Rural	17.408	40,3 %

La matriz completa de metas, correspondiente a las 1.848 combinaciones de departamento, régimen, sexo, grupo de edad y zona, se generó en 03_Encuesta/01_Tamaño_Muestra/Output/04_asignacion_sexo_edad10_departamento_regimen.xlsx. El **Anexo E — Matriz de cuotas**, organizado hasta ahora en una hoja por región (336 combinaciones), queda **pendiente de regenerar** a partir de este archivo, con una hoja por departamento.

4.3.10 Alcance de los resultados por departamento

Decisión metodológica adoptada, con alcance condicionado. La ampliación del tamaño objetivo a 43.176 participaciones (4.5) abre la posibilidad de producir resultados representativos por departamento, pero esa posibilidad está **condicionada a que la meta de cada departamento se cumpla efectivamente al cierre del periodo de recolección**. La respuesta a la invitación es voluntaria (4.1), por lo que alcanzar la meta departamental es un resultado de la operación, no una propiedad garantizada por el diseño.

En consecuencia:

- Un departamento que alcance su meta de 1.278 a 1.313 participaciones (según su tamaño poblacional; 4.5) puede, en principio, habilitarse para la producción de resultados representativos a ese nivel para los indicadores construidos con Parte 1 y Parte 2, que responde la totalidad de las personas captadas.
- Un departamento que no alcance su meta al cierre del periodo de recolección **no debe tratarse como representativo a nivel departamental**; sus resultados deberán limitarse a análisis descriptivos,

agregarse al nivel de región, o presentarse con las advertencias metodológicas correspondientes, conforme al criterio general ya establecido para cualquier dominio con baja participación (4).

Esta ampliación no extiende la representatividad departamental a los indicadores de Parte 3 (módulo específico). Aun si un departamento alcanza su meta de 1.278 a 1.313 participaciones en Parte 1-2, el número de personas que además accede a un módulo determinado dentro de ese departamento es sustancialmente menor, por la doble dilución del sorteo Bernoulli ($\pi = 0,8$) y de la asignación aleatoria entre los módulos de un mismo prestador ($P = 1/3$ en EPS, $1/4$ en IPS, 1 en el gestor; 4.2). Por ejemplo, para un departamento con meta de 1.313 participaciones, el número esperado de personas que elige un prestador con IPS y recibe un módulo IPS específico es del orden de $1.313 \times 0,8 \times P(\text{elige IPS})/4$, una fracción pequeña del total departamental. Este documento no define un tamaño objetivo por combinación departamento $\times$ módulo, y no debe interpretarse que la ampliación aquí adoptada garantiza esa desagregación.

4.3.11 Conformación periódica del marco

El marco de invitación se conforma periódicamente durante el año con las personas que registran una atención en salud en el periodo correspondiente (4.1). Esta conformación periódica reemplaza la actualización cada cuatro meses de la base de usuarios habilitados prevista en el esquema anterior.

La conformación del marco debe distinguirse de la BDUA con corte a marzo de 2026 utilizada como referencia poblacional para distribuir las metas de respuesta (4.3) y, más adelante, para los totales de calibración: aquella es un corte fijo, adoptado como parámetro del diseño para todo el año de referencia, mientras que el marco de invitación se renueva en cada periodo.

La frecuencia de conformación del marco determina el tiempo transcurrido entre la atención y la invitación. Una frecuencia baja aumenta el potencial sesgo de recuerdo y se aleja de lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución 1642 de 2026, según el cual la ENUS «captura la experiencia del afiliado tras cada atención en salud» (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). La frecuencia se registra como pendiente de definición en 4.1.

4.3.12 Papel de las EPS, IPS y gestores en la invitación

La Resolución 1642 de 2026 obliga a las EPS, IPS y gestores farmacéuticos a promover activamente el uso del aplicativo móvil oficial entre sus afiliados y usuarios en los puntos de atención, mediante estrategias que incluyan carteles informativos, mensajes de texto y notificaciones push (art.

12, num. 1), y a las EPS a informar y orientar a sus afiliados sobre la descarga, el acceso y el uso del aplicativo (art. 10, par. 1) (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Estas acciones complementan la invitación que realiza el Ministerio a todas las personas del marco.

La necesidad de este apoyo responde a una condición operativa relevante: **no todas las personas de la población objetivo disponen de teléfono inteligente, conexión a Internet u otros medios digitales**. Las entidades deben facilitar el acceso asistido, de manera que el usuario conserve la autonomía para decidir si participa y que las respuestas sean registradas directamente por él o con su consentimiento y acompañamiento.

Las entidades no constituyen unidades de selección ni tienen metas de respuesta propias. El número de respuestas de los usuarios de cada EPS, IPS o gestor depende de la respuesta efectiva a la invitación y no es una dimensión controlada por el diseño.

4.3.13 Diferenciación conceptual para el análisis

Para la interpretación de los resultados es necesario distinguir entre los conceptos utilizados para organizar la operación y aquellos utilizados para producir y analizar los resultados. Aunque una misma variable puede intervenir en más de una de estas funciones, su propósito estadístico es diferente.

- *Meta de respuesta*. Número de respuestas que se espera obtener en una celda definida por departamento, régimen, sexo, grupo de edad y zona. Sirve para monitorear la operación y reforzar la invitación donde la respuesta sea insuficiente; no restringe la participación. Responde a la pregunta: *¿cuántas respuestas se espera obtener en cada grupo?*
- *Estrato*. Partición de la población dentro de la cual se realiza una selección probabilística independiente (Cochran 1977; Kish 1965). En la ENUS 2026 no hay selección dentro de celdas, porque se invita a todo el marco; las celdas de meta de respuesta no son estratos.
- *Dominio de análisis*. Grupo para el cual se desea producir un resultado, como un departamento, una región, el régimen subsidiado o una EPS. La región tiene un tamaño esperado porque agrega metas departamentales; dominios como EPS, IPS o tipo de servicio no tienen meta propia y su tamaño depende de la respuesta efectiva. En síntesis: *la meta define cuánto se espera obtener; el dominio define para quién se produce un resultado*.
- *Variable de calibración*. Variable auxiliar con totales conocidos en la BDUA que se utiliza para ajustar los pesos por no respuesta. Responde a la pregunta: *¿contra qué información poblacional se ajustan los pesos de quienes respondieron?*

Cuadro 4.10: Diferenciación conceptual entre meta de respuesta, estrato, dominio y variable de calibración, ENUS 2026.

Concepto	Función principal	Ejemplo en ENUS 2026
Meta de respuesta	Monitorear la respuesta por grupo	Meta para Atlántico × Subsidiado × Femenino × 30–39 × Urbano
Estrato	Organizar una selección probabilística dentro de una partición	No aplica: se invita a todo el marco
Dominio	Definir un grupo para producir o analizar resultados	Régimen subsidiado, un departamento, una región o una EPS
Variable de calibración	Ajustar los pesos por no respuesta con totales conocidos	Sexo, edad, régimen, departamento o zona

Una misma variable puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, **departamento** define una meta de respuesta, un dominio de análisis y una variable de calibración; **región**, al ser una agregación de departamentos, funciona como dominio y potencialmente como variable de calibración, pero no define directamente una celda. Lo que cambia no es la variable, sino la función que cumple en cada etapa.

4.3.14 Alcance de los análisis por dominio y estructura de la participación

La posibilidad de producir resultados para un dominio determinado dependerá de la participación efectiva de los usuarios que pertenecen a dicho dominio. En consecuencia, la definición de una categoría como dominio potencial de análisis no implica que necesariamente se disponga de un número suficiente de observaciones para producir estimaciones con la precisión o estabilidad requerida.

Esta consideración es particularmente relevante para variables que no hacen parte de las metas de respuesta, entre ellas las relacionadas con la EPS, IPS, gestor, tipo de servicio recibido u otras características institucionales. La distribución de participantes en estas categorías dependerá de la participación efectiva de los usuarios y, por tanto, no puede garantizarse mediante el tamaño total de la muestra.

De igual manera, las celdas de meta de respuesta no deben interpretarse como garantía de suficiencia analítica para todos los cruces posibles entre variables. A medida que aumenta el nivel de desagregación, el número de

observaciones disponibles en cada subgrupo puede disminuir y afectar la estabilidad de los resultados.

Por esta razón, la producción de resultados desagregados deberá considerar, para cada dominio, el número efectivo de observaciones, la distribución de los pesos, la variabilidad de los estimadores y los criterios de calidad estadística definidos para la ENUS 2026. Los resultados correspondientes a dominios con baja participación deberán ser identificados y, cuando corresponda, limitarse a análisis descriptivos o presentarse con las advertencias metodológicas pertinentes.

La interpretación de los resultados también deberá considerar el posible efecto de la no respuesta. La calibración con la BDUA ajusta la composición de quienes responden en las variables auxiliares utilizadas, pero no elimina necesariamente diferencias entre las personas que responden y aquellas que, habiendo sido invitadas, no responden. Estas diferencias pueden presentarse en variables observadas y no observadas y afectar la representatividad de los resultados (Elliott y Valliant 2017; Wang y Valliant 2015; Lee y Valliant 2006).

En consecuencia, el carácter probabilístico de la invitación no constituye por sí mismo una garantía de representatividad para cualquier nivel de desagregación. El alcance final de los análisis estará condicionado por la tasa de respuesta alcanzada, la composición alcanzada de la muestra y los resultados de los procedimientos posteriores de ponderación y calibración.

Capítulo 5

Papel de las EPS y operativo de campo

Este capítulo documenta el papel de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos dentro de la operación de campo de ENUS 2026, y desarrolla las implicaciones operativas de la ausencia, en los insumos técnicos disponibles, de un mecanismo documentado de difusión o cierre activo de la captación. La forma en que se asigna el módulo de Parte 3 que responde un usuario —el sorteo Bernoulli, la elección de prestador y la asignación aleatoria de módulo dentro del prestador elegido— es una cuestión de estructura del instrumento y se documenta de forma completa en el capítulo de diseño muestral (4.2); no se repite aquí.

5.1 ¿Qué es ClicSalud?

ClicSalud es la aplicación digital mediante la cual se implementa la recolección de ENUS 2026: es el canal a través del cual el usuario se identifica, responde el cuestionario y navega entre preguntas de acuerdo con las reglas del árbol de decisión. Es, por tanto, el mecanismo concreto sobre el que operan tanto la captación de usuarios como la relación con las EPS e IPS que se desarrolla en este capítulo —la EPS se reporta dentro de *ClicSalud*, y es *ClicSalud* la que finalmente registra la participación de cada usuario, con independencia de que exista o no un canal institucional que lo dirija hacia la aplicación—. La descripción completa de su estructura, pantallas y recorrido de uso se documenta en el capítulo de instrumento de recolección (6); aquí solo se introduce lo necesario para situar el papel de las EPS e IPS frente a ella.

5.2 Importancia de las EPS en la operación

La Resolución 1642 de 2026 adopta la ENUS como instrumento oficial y permanente y dispone explícitamente que la encuesta debe generar información sobre el **desempeño de las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos**, mediante indicadores organizados de acuerdo con los atributos de calidad definidos en la normativa vigente (Ministerio de Salud y Protección Social 2026) (1). Las EPS no son, por tanto, un actor incidental de la operación: son, junto con las IPS y los gestores farmacéuticos, el objeto último de medición de buena parte de los indicadores que la ENUS 2026 está llamada a producir.

En consonancia con ese mandato, el diseño de ENUS 2026 no contempla una etapa de selección de EPS, IPS o gestores farmacéuticos: **todas las entidades del universo institucional son, en principio, canal potencial de acceso y objeto de medición**, sin un marco muestral propio a nivel institucional ni una fase probabilística previa de selección de actores (4). La cuota y la captación operan exclusivamente a nivel de usuario; ninguna EPS, IPS o gestor queda excluido de antemano de la posibilidad de que sus afiliados o usuarios participen y de que su desempeño sea evaluado.

5.3 La EPS como dato de identificación del usuario

En *ClicSalud*, la EPS del usuario se captura como parte de su proceso de identificación: la aplicación presenta un listado de EPS del cual el usuario selecciona la propia antes de continuar, de forma análoga a las demás variables de identificación —documento, ubicación geográfica, régimen— (??). Esta selección identifica al usuario y, más adelante, permite reportar resultados por EPS; no constituye un mecanismo de selección de la EPS como unidad muestral, y la EPS reportada no interviene en la construcción de la cuota ni en la calibración de los pesos (4).

5.4 Participación de las EPS e IPS en la captación: sin evidencia de un canal activo

Los insumos técnicos revisados —*ClicSalud* y los datos del árbol de decisión que gobierna su navegación— no documentan un mecanismo por el cual las EPS o las IPS actúen como canal institucional para invitar, promover o facilitar activamente la participación de sus propios usuarios en ENUS

2026: no hay evidencia de envío de invitaciones, códigos de acceso distribuidos en puntos de atención, listados de usuarios remitidos por el actor institucional, ni de un procedimiento de monitoreo o cierre de la captación gestionado por estas entidades. Esta ausencia de evidencia es distinta, y adicional, a la ya documentada para el mecanismo de cierre de cuota dentro de la propia aplicación (??): aquí se trata específicamente de la falta de un canal institucional de difusión hacia los usuarios de cada EPS o IPS, no del comportamiento interno de *ClicSalud*.

Conforme al principio de no presentar mecanismos no respaldados por los insumos, este documento no describe un procedimiento operativo de difusión, promoción o reclutamiento institucional. Si en la operación real las EPS o las IPS cumplen un papel activo de promoción o facilitación del acceso a la encuesta, esa información debe ser suministrada por el equipo metodológico ENUS para incorporarla aquí con la evidencia correspondiente.

En síntesis, con la evidencia disponible, las EPS y las IPS participan en ENUS 2026 como categoría de identificación del usuario y como objeto de medición de los indicadores de desempeño —no como unidades de muestreo ni, hasta donde documentan los insumos técnicos, como canales activos de reclutamiento o difusión.

5.5 Métodos de difusión: recomendación metodológica

Recomendación metodológica. Dada la ausencia de un canal institucional documentado, y dado que la representatividad de la muestra por cuotas depende directamente del volumen y la diversidad de usuarios que llegan a *ClicSalud* (??), se recomienda que el equipo operativo de ENUS 2026 evalúe la incorporación de mecanismos de difusión que involucren activamente a las EPS y las IPS. Se organizan a continuación en tres frentes: los canales propios de cada entidad, los que se apoyan en capacidades que *ClicSalud* ya tiene implementadas, y los de coordinación institucional.

5.5.1 Canales propios de EPS e IPS

- **Puntos de atención física.** Divulgación mediante material impreso o código QR de acceso directo en las sedes de atención al usuario de EPS e IPS, en el mismo punto en que hoy se entrega la Carta de Derechos y Deberes (1).
- **Canales digitales propios de la EPS.** Envío de la invitación a través de los canales de comunicación que cada EPS ya mantiene con sus afiliados (aplicaciones propias, mensajería, correo electrónico o portales de usuario), sujeto a la disponibilidad y disposición de cada entidad.

- **Momento posterior a la atención.** Invitación a participar inmediatamente después de recibir un servicio en una IPS, cuando la experiencia del usuario está más reciente y el sesgo de recuerdo es menor —en línea con el objetivo específico de minimizar el sesgo de recuerdo ya adoptado para la operación (2).
- **Líneas de atención al usuario y PQRS.** Mención de la encuesta como opción de cierre en las líneas telefónicas y canales de peticiones, quejas y reclamos que EPS e IPS ya operan de manera regular, sin que ello sustituya el canal de participación formal en *ClicSalud*.

5.5.2 Canales apoyados en capacidades ya implementadas en *ClicSalud*

- **Notificación dirigida a partir de atenciones detectadas.** *ClicSalud* ya presenta al usuario, al ingresar al módulo de encuesta, una sección de atenciones de salud detectadas en los últimos seis meses —consulta externa, urgencias, exámenes y procedimientos, con fecha e institución— (6). Esa misma capacidad de detección podría reutilizarse para enviar una notificación push focalizada poco después de registrarse una atención, en lugar de depender exclusivamente de que el usuario ingrese por iniciativa propia.
- **Llamado a participar desde la pestaña Desempeño.** La pestaña “Desempeño” de *ClicSalud* ya muestra al usuario un tablero de indicadores de calidad de su EPS, construido sobre atributos análogos a los que mide ENUS 2026 —acceso, tiempo de espera, humanización del trato, entrega de medicamentos— (6). Podría incorporarse allí un llamado a participar en la encuesta, presentando la relación directa entre responder y la información que ese mismo tablero despliega.
- **Acceso asistido en el punto de atención.** Para el paso de verificación por SMS, *ClicSalud* ya contempla que un funcionario asista al usuario sin celular propio mediante una tableta institucional en el punto de atención de su EPS (6); ese mismo canal asistido podría promoverse activamente como vía de acceso para usuarios con menor autonomía digital, en lugar de operar solo como respaldo ante la ausencia de celular.

5.5.3 Coordinación institucional

- **Campañas institucionales del Ministerio.** Divulgación general a través de los canales del Ministerio de Salud y Protección Social, complementaria a los canales institucionales de cada EPS o IPS.
- **Articulación con la Superintendencia Nacional de Salud y los entes de inspección, vigilancia y control,** en la medida en que la participación de los usuarios en ENUS 2026 es también insumo para el

seguimiento del desempeño de las EPS que esos entes supervisan (1).

5.5.4 Trazabilidad del canal de difusión

Si el equipo operativo adopta alguno de estos mecanismos, se recomienda adicionalmente capturar en *ClicSalud* el canal por el cual cada usuario llegó a la aplicación (identificación por documento vs. QR institucional, notificación push, invitación de EPS/IPS, etc.). Sin este dato no es posible, en etapas posteriores, evaluar si un canal de difusión concentra la captación en perfiles particulares de usuario —lo que agregaría una fuente adicional de autoselección a la ya documentada en el mecanismo de cuotas (??)— ni distinguir esa condición de la composición demográfica que sí controla la cuota.

Estas alternativas se presentan exclusivamente como recomendación metodológica para consideración del equipo operativo; ninguna de ellas debe interpretarse como un mecanismo actualmente implementado en ENUS 2026 —salvo la detección de atenciones recientes y el acceso asistido en tableta, que sí están documentados en el instrumento pero no como mecanismos de difusión activa—, ni su eventual adopción está respaldada, a la fecha, por los insumos técnicos revisados para este documento.

5.6 Preguntas frecuentes

¿Cuándo puede participar un usuario en ENUS 2026? Cuando está afiliado al SGSSS y ha utilizado al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de la encuesta durante el trimestre de referencia correspondiente (3.2). La recolección es continua a lo largo del año, de modo que un usuario puede acceder a *ClicSalud* en cualquier momento posterior a la utilización del servicio, dentro del trimestre en curso.

¿Qué pasa si no he utilizado servicios de salud recientemente? No es elegible: el criterio de elegibilidad exige un registro BDUa de uso efectivo de un servicio de EPS, IPS o gestor farmacéutico (3.2), por lo que una persona sin ese registro no está habilitada para evaluar el prestador correspondiente. **Pendiente de definición:** el módulo EPS 1 conserva un contenido originalmente dirigido a “no usuarios” (barreras de acceso) que es inconsistente con este criterio de elegibilidad; se documenta esta inconsistencia, sin resolverla, en 4.2.

¿Qué pasa si me cambié de EPS? La EPS se captura por autorreporte —el usuario la selecciona de un listado— y no se valida individualmente contra el registro de BDUa en el momento de responder; la validación contra BDUa que sí ocurre se limita a confirmar que la afiliación al SGSSS esté

activa, no a verificar que la EPS reportada coincida con la registrada en un momento específico (??). Los insumos técnicos disponibles no documentan una regla específica para el caso de un usuario que se afilió recientemente a una EPS distinta de aquella con la que recibió el servicio sobre el que responde; si en la operación real existe un criterio para este caso, debe incorporarse aquí con su evidencia correspondiente.

¿Puedo participar más de una vez? Sí, pero no para evaluar a la misma entidad. Un usuario puede acceder a *ClicSalud* y diligenciar el cuestionario en más de una ocasión durante el periodo de recolección; sin embargo, una vez que diligencia Parte 3 para una entidad determinada (EPS, IPS o gestor farmacéutico), esa entidad queda bloqueada por un año calendario para ese mismo usuario (4.2). El bloqueo opera por entidad evaluada y no impide que el mismo usuario participe nuevamente para evaluar una entidad distinta de la ya evaluada, hasta un máximo de tres registros completos (uno por prestador).

¿Qué pasa si empiezo el cuestionario y no lo termino? *ClicSalud* conserva la sesión de identificación ya verificada, pero los insumos disponibles no documentan un mecanismo que guarde el avance de un cuestionario parcialmente respondido para permitir su reanudación (??). El criterio con el que un registro incompleto se incluye o se excluye de la base analítica se documenta, en la medida en que los insumos lo permiten, en el capítulo de procesamiento (??).

¿Qué pasa si mi celda demográfica ya alcanzó su meta de cuota? Con la evidencia disponible, nada distinto: *ClicSalud* no documenta una verificación de disponibilidad de la celda de cuota en el momento en que el usuario la completa, por lo que todo usuario elegible que se clasifica avanza y es aceptado, independientemente del estado de su celda (??).

¿Se selecciona un subconjunto de EPS, IPS o gestores farmacéuticos para participar en ENUS 2026? No. El diseño no contempla una etapa de selección institucional: todas las entidades del universo son, en principio, canal potencial de acceso y objeto de medición (4).

¿Qué ocurre cuando el usuario reporta su EPS en *ClicSalud*? Se registra como dato de identificación, de la misma forma que el documento o la ubicación geográfica. No convierte a la EPS en una unidad muestral ni interviene en la construcción de la cuota o en la calibración de los pesos.

¿Las EPS o las IPS invitan o promueven activamente la participación de sus usuarios? Con la evidencia técnica disponible, no hay documentación de un canal institucional de este tipo (invitaciones, códigos de acceso, listados remitidos). Si en la operación real existe, debe incorporarse con su evidencia correspondiente.

¿La EPS o la IPS determinan qué módulo del cuestionario responde el usuario? No directamente. El usuario elige cuál prestador desea evaluar

(EPS, IPS o gestor farmacéutico), pero el módulo específico dentro de ese prestador se asigna al azar, no según el tipo de servicio efectivamente recibido. La lógica completa de esa asignación —sorteo Bernoulli, elección de prestador y asignación aleatoria de módulo— se documenta en el capítulo de diseño muestral (4.2), no en este capítulo.

¿Existen ya métodos de difusión institucional definidos para ENUS 2026? No. Los propuestos en la sección anterior son una recomendación metodológica para evaluación del equipo operativo, no una decisión adoptada ni un mecanismo en funcionamiento.

¿Dónde se explica en detalle qué es y cómo funciona *ClicSalud*? En el capítulo de instrumento de recolección (6), que documenta su estructura, pantallas y recorrido completo de uso.

Capítulo 6

Instrumento de recolección: ClicSalud

El instrumento de ENUS 2026 se administra en su totalidad a través de *ClicSalud*, la aplicación en la que se implementan la identificación del usuario, la validación de su elegibilidad, la navegación del árbol de decisión y el registro de las respuestas. Este capítulo documenta la estructura funcional de la aplicación como guía de uso paso a paso —qué ve y qué hace un usuario en cada pantalla— con evidencia visual de cada paso, siguiendo el recorrido completo desde el ingreso a la aplicación hasta el cuestionario de ENUS 2026.

Nota sobre la evidencia visual (septiembre de 2026). El mecanismo de captación de *ClicSalud* se actualizó (sorteo Bernoulli, elección de prestador y asignación aleatoria de módulo; 4.2) con posterioridad a la toma de las capturas de pantalla que ilustran los pasos 9 a 11. El texto de esos pasos se actualizó con base en el código fuente vigente de la aplicación, pero las capturas de pantalla correspondientes (figuras fig-clicsalud-06 y fig-clicsalud-12) **no se han vuelto a tomar** y muestran pantallas de la versión anterior. Se conservan únicamente donde su contenido no cambió (identificación, verificación, pantallas informativas) y se marcan explícitamente como pendientes de actualización donde sí cambió.

6.1 Estructura general de la aplicación

La aplicación se organiza en doce pantallas identificables, agrupadas en tres bloques funcionales:

Bloque	Pantalla	Función
Acceso e identificación	Identificación	Captura de documento y EPS del usuario
Acceso e identificación	Verificación BDU A	Validación de afiliación activa contra BDU A
Acceso e identificación	Código SMS	Verificación del usuario mediante código enviado por mensaje de texto
Acceso e identificación	Reingreso	Reconocimiento automático de un usuario con sesión ya verificada en el mismo dispositivo
Navegación principal	Inicio	Pantalla principal con acceso a los demás módulos
Navegación principal	Módulo Encuesta ENUS	Acceso al cuestionario de ENUS 2026 (árbol de decisión, 4)
Navegación principal	Módulo Derechos y Deberes	Contenido institucional informativo, ajeno al cuestionario
Navegación principal	Módulo Carta de Desempeño	Contenido institucional informativo, ajeno al cuestionario
Navegación principal	Normatividad	Contenido normativo de referencia, ajeno al cuestionario
Contenido adicional	Publicidad MinSalud	Pantalla promocional mostrada al ingresar a la aplicación
Contenido adicional	Flashcards	Visor de contenido institucional en formato de tarjetas resumen

Bloque	Pantalla	Función
Contenido adicional	Encuesta de verificación	Cuestionario breve, distinto del cuestionario de ENUS 2026, asociado en la aplicación a los artículos 5 y 6 de la normatividad de referencia que la propia aplicación cita

De estas doce pantallas, únicamente el módulo Encuesta ENUS conduce al instrumento que documenta este trabajo metodológico. Las pantallas de Derechos y Deberes, Carta de Desempeño, Normatividad, Publicidad MinSalud y Flashcards son contenido institucional de la aplicación sin relación con la recolección de ENUS 2026; la Encuesta de verificación es un instrumento distinto, cuyo contenido y propósito no se documentan en este trabajo por no ser parte del alcance de ENUS 2026 (3).

6.2 Guía de uso: recorrido completo de la aplicación

Esta sección documenta, paso a paso y con evidencia visual, el recorrido completo de un usuario dentro de *ClicSalud*: desde el ingreso a la aplicación hasta la respuesta de una pregunta del cuestionario de ENUS 2026.

6.2.1 Paso 1. Mensaje institucional de bienvenida

Al abrir la aplicación, el usuario ve primero una pantalla informativa institucional del Ministerio de Salud y Protección Social, con la opción de omitirla para continuar directamente a la identificación.



Figura 6.1: Pantalla de bienvenida institucional, previa al acceso a la identificación.

6.2.2 Paso 2. Identificación por documento

El usuario selecciona su tipo de documento e ingresa su número de identificación. Este es el primer paso de la elegibilidad documentada en el capítulo de población objetivo (3.2): sin un documento válido, el usuario no puede continuar.



10:47 100%

Ministerio de Salud y Protección Social

Identifíquese

Paso 1 de 3 · Solo necesita su documento.
Se identifica una sola vez para toda la aplicación.

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de documento

1020304050

Solo números · Sin puntos ni guiones

Continuar →

Demo contributivo: 1020304050 · 79456123 · 1193012345
Subsidiado: 1073512836 · 43215678 · Sin atenciones: 11111111
No afiliado: 99999999

Sus datos se usan solo para verificación. Tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012 — Habeas Data.

Figura 6.2: Identificación del usuario por tipo y número de documento.

6.2.3 Paso 3. Verificación por código SMS

Tras enviar el documento, la aplicación indica que está enviando un código de verificación por mensaje de texto al número registrado, y a continuación presenta un campo de cuatro dígitos para que el usuario lo ingrese. Este es el segundo paso de la elegibilidad. La aplicación advierte que, si el usuario no dispone de celular, un funcionario puede asistirlo con la tableta institucional del punto de atención de su EPS —un canal de acceso asistido, adicional al acceso digital directo.



Figura 6.3: Verificación por código enviado por SMS.

6.2.4 Paso 4. Verificación BDUA

Superada la verificación por SMS, la aplicación presenta los datos de afiliación del usuario —nombre, EPS, régimen, municipio y departamento— obtenidos de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), junto con la fecha de corte de la consulta y la confirmación de que la afiliación está activa. El usuario debe confirmar que estos datos son correctos para continuar; este es el tercer y último paso de la elegibilidad. La pantalla advierte además que, al confirmar, la sesión queda guardada en el dispositivo (??).



Figura 6.4: Verificación BDUA: confirmación de la afiliación activa y de los datos institucionales del usuario.

6.2.5 Paso 5. Pantalla de Inicio y navegación principal

Confirmada la identidad, el usuario llega a la pantalla de Inicio, que lo saluda por su nombre y muestra su EPS y régimen. Desde aquí puede acceder a tres funciones —conocer sus derechos y deberes, consultar el desempeño de su EPS o participar en la encuesta de experiencia—, además de ajustar el tamaño de letra de la aplicación. En la parte inferior, una barra de navegación con cinco pestañas (Inicio, Derechos, Desempeño, Encuesta, Normas) permite moverse entre las secciones principales de la aplicación en cualquier momento.

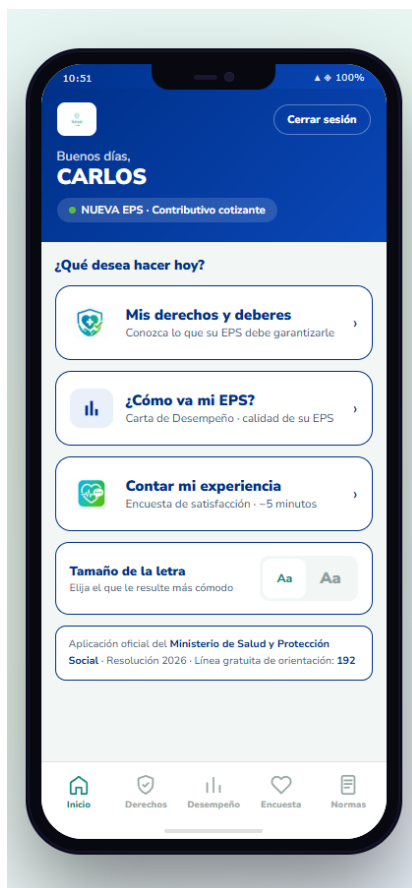


Figura 6.5: Pantalla de Inicio, con el usuario ya identificado y acceso a los módulos de la aplicación.

6.2.6 Paso 6. Pestaña Derechos

La pestaña “Derechos” presenta la Carta de Derechos y Deberes del afiliado en tarjetas rápidas por tema (derechos del afiliado, deberes, muerte digna, mecanismos de protección, información de la EPS), un acceso a la Carta específica de cada EPS y una encuesta de verificación distinta de ENUS 2026 (6.1). Es contenido institucional informativo, sin relación con el cuestionario de ENUS 2026.



Figura 6.6: Pestaña Derechos: Carta de Derechos y Deberes por tarjetas temáticas.

6.2.7 Paso 7. Pestaña Desempeño

La pestaña “Desempeño” muestra un tablero de indicadores de calidad de la EPS del usuario, con calificación de experiencia, indicadores por atributo (acceso, tiempo de espera, humanización del trato, entrega de medicamentos, satisfacción global), un comparativo entre EPS y una serie de tendencia. Es, igualmente, contenido informativo institucional; no forma parte del cuestionario de recolección, aunque los atributos que despliega son ilustrativos del tipo de indicadores que una operación como ENUS puede producir (ver capítulo de indicadores).



Figura 6.7: Pestaña Desempeño: tablero de indicadores de calidad de la EPS del usuario.

6.2.8 Paso 8. Pestaña Normas

La pestaña “Normas” enumera el marco normativo que respalda la aplicación y los derechos del usuario, incluida una referencia explícita a una “Resolución MSPS 2026” como lineamiento de adopción de la ENUS. Es, igualmente, contenido de referencia, sin preguntas ni captura de información.



Figura 6.8: Pestaña Normas: marco normativo de referencia de la aplicación.

6.2.9 Paso 9. Acceso al módulo Encuesta ENUS

Desde la pestaña “Encuesta” o desde la opción “Contar mi experiencia” en Inicio, el usuario llega a la pantalla de entrada del cuestionario de ENUS 2026, que muestra su sesión activa y verificada, y una vista previa de los prestadores disponibles para evaluar —los que tiene habilitados en BDUA y que no estén bloqueados por haber sido evaluados en el último año (4.2)—. El usuario inicia la encuesta desde esta pantalla.

Pendiente de actualización visual. La figura fig-clicsalud-06-modulo-encuesta.png corresponde a la versión anterior de esta pantalla, que mostraba en su lugar las atenciones de salud detectadas para el usuario (FEVRIPS); no se incluye aquí por no representar ya la pantalla vigente.

6.2.10 Paso 10. Parte 2 --- Preguntas comunes

Al iniciar la encuesta, el usuario responde Parte 2: once preguntas comunes de respuesta directa, tomadas de la sección de trazadoras y transversales del instrumento (4.2). Las dos primeras coinciden con los ejemplos capturados en las figuras siguientes:

1. ¿Quién se encuentra diligenciando esta encuesta? (Usted mismo / Un pariente o tutor legal / Otra persona)
2. ¿Cuenta usted con algún plan voluntario de salud? (Plan Complementario / Medicina Prepagada / Póliza de salud / Ninguno)
3. ¿Cuál es su percepción general de su salud? (Excelente / Muy buena / Buena / Regular / Mala / Muy mala)
4. En los últimos 6 meses, ¿ha utilizado un servicio de salud? (Sí / No)
5. En los últimos 6 meses, ¿ha cambiado de EPS o se afilió por primera vez a una EPS? (Sí / No)
6. ¿Quién le ayudó a gestionar el servicio de salud que requería? (EPS / Secretaría de Salud / IPS pública / IPS privada de su EPS / IPS privada particular / Ninguna de las anteriores)
7. ¿Cuál de los siguientes servicios utilizó la última vez? (Urgencias / Hospitalización / Cirugía / Consulta Externa / Atención Domiciliaria / Entrega de medicamentos o dispositivos médicos / Laboratorio clínico / Imágenes diagnósticas / Otro / Ninguna de las anteriores)
8. ¿Se encuentra usted en estado de embarazo? (Sí / No)
9. ¿Ha sido diagnosticado con alguna de estas condiciones? (Hipertensión Arterial / Diabetes Mellitus Tipo 2 / Hemofilia / Enfermedad Huérfana o Rara / VIH / Hepatitis C / Artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes / Cáncer / Ninguna de las anteriores)
10. En los últimos seis meses, ¿hubo algún momento en el que tuvo un problema de salud y requería atención médica, pero decidió no acudir al servicio médico? (Sí / No)
11. ¿Conoce o ha tenido acceso al informe anual de tuteladas? (Sí / No)

Cada pregunta se presenta en pantalla completa, con un indicador de avance ("Pregunta N de 11") y un botón "Siguiente" para continuar. Las dos figuras siguientes siguen siendo válidas como ejemplo del diseño de pantalla (tarjeta de pregunta, opciones, barra de progreso): el texto de sus preguntas no cambió, aunque el indicador "de 6" que muestran quedó desactualizado por el aumento a once preguntas.

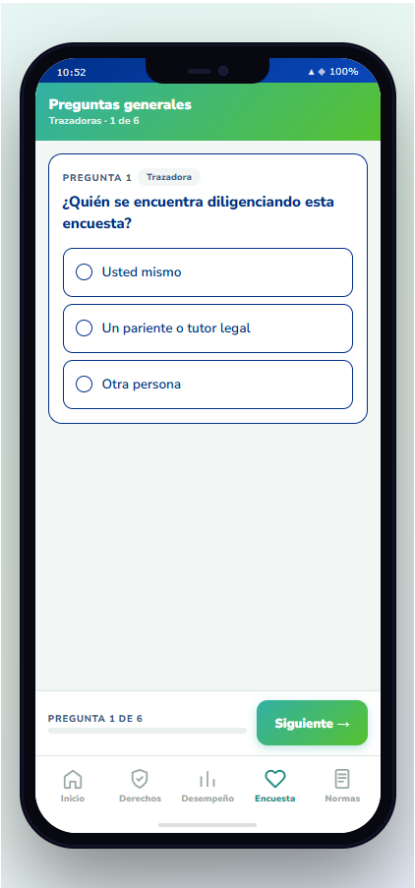


Figura 6.9: Primera pregunta de Parte 2: identificación de quién diligencia la encuesta.

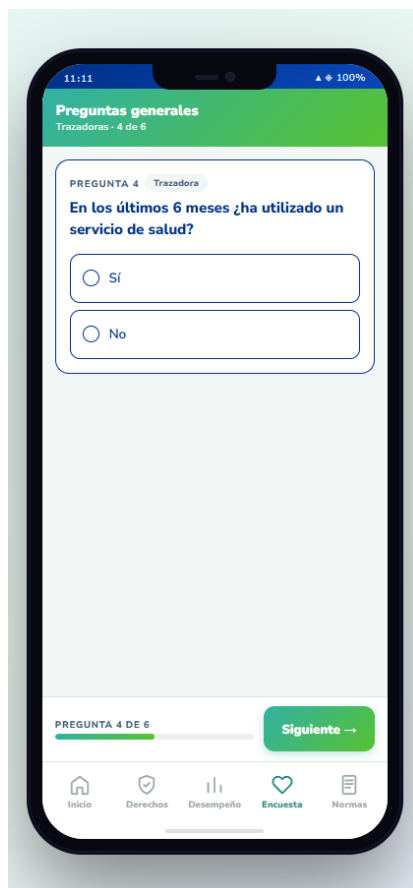


Figura 6.10: Cuarta pregunta de Parte 2: uso de servicios de salud en los últimos seis meses.

6.2.11 Paso 11. Sorteo, elección de prestador y módulo asignado

Al terminar Parte 2 de su primer ingreso, la aplicación ejecuta el sorteo Bernoulli ($u \sim \text{Uniforme}(0, 1), \pi = 0, 8$) sin mostrar una pantalla intermedia: si el resultado es negativo, el usuario pasa directamente a la pantalla de agradecimiento; si es positivo, se le presenta una pantalla para **elegir cuál prestador desea evaluar** (EPS, IPS o gestor farmacéutico) entre los que tiene habilitados y no bloqueados. Elegido el prestador, la aplicación asigna al azar uno de sus módulos disponibles y presenta sus preguntas bajo el encabezado “Parte 3” y el código del módulo asignado (por ejemplo, “Parte 3 · Cod. eps_m3”), sin la etiqueta de forma (“Forma A/B”) de la versión anterior de la aplicación, que fue retirada junto con el mecanismo

de selección determinística por servicio efectivamente recibido.

Pendiente de actualización visual. La figura `fig-clicsalud-12-modulo-forma-a.png` corresponde a la versión anterior de esta pantalla (con las etiquetas “Forma A”, “Cod. 01” y “Bloque 1 de 3”, ya retiradas) y a la pantalla de elección de prestador no existe todavía una captura; no se incluyen aquí por no representar la aplicación vigente.

La correspondencia formal entre la terminología de “módulos” utilizada en este documento a partir del árbol de decisión (4) y cualquier esquema de identificación interno de la aplicación se desarrolla, cuando corresponda, en el capítulo de reconciliación de estructuras.

6.3 Sesión y reingreso

El comportamiento de sesión —persistencia en el dispositivo mediante la clave `clicsalud_sesion_v1`— se documenta de forma completa en el capítulo de instrumento de recolección (paso 9 y siguientes) y no se repite aquí. La pantalla de Reingreso es la implementación visual de ese reconocimiento automático de sesión. Nótese que, a diferencia de la sesión de identificación, sí existe un mecanismo aleatorio en la captación: el sorteo Bernoulli y la asignación de módulo descritos en 4.2, que operan después de que la persona ya fue clasificada dentro de su celda de cuota, no dentro de ella.

6.4 Almacenamiento de datos durante la recolección

Los insumos técnicos disponibles no documentan si las respuestas del cuestionario se registran en tiempo real conforme el usuario avanza, o únicamente al finalizar el módulo completo, ni un mecanismo de sincronización ante pérdida de conectividad durante la recolección. Tampoco documentan una política de tiempo de espera (*timeout*) de sesión ni un criterio explícito para distinguir un abandono del cuestionario de una interrupción temporal. En ausencia de esa evidencia, este documento no describe un mecanismo específico de almacenamiento incremental ni de tratamiento de interrupciones; el criterio con el que un registro incompleto se incluye o se excluye de la base analítica se documenta, en la medida en que los insumos lo permitan, en el capítulo de procesamiento.

6.5 Alcance de esta documentación frente a otras estructuras del instrumento

Este capítulo documenta la estructura funcional de *ClicSalud* como aplicación de recolección, con evidencia visual de su recorrido completo, salvo en los pasos donde esa evidencia quedó pendiente de actualización (pasos 9 y 11). La estructura del cuestionario mismo —los nueve desenlaces y ocho módulos finales que resultan del sorteo Bernoulli, la elección de prestador y la asignación aleatoria de módulo— es la que se ha utilizado de forma consistente en todo este documento y se documenta de forma completa en el capítulo de diseño muestral (4.2).

Referencias

Agency for Healthcare Research and Quality. 1995. *Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)*. <https://www.ahrq.gov/cahps/index.html>.

Agency for Healthcare Research and Quality. 2024. «CAHPS Measures of Patient Experience». <https://www.ahrq.gov/cahps/consumer-reporting/measures/index.html>.

Baker, Reg, J. Michael Brick, Nancy A. Bates, et al. 2013. «Summary Report of the AAPOR Task Force on Non-probability Sampling». *Journal of Survey Statistics and Methodology* 1 (2): 90-143.

Cochran, William G. 1977. *Sampling Techniques*. 3.^a ed. Wiley.

Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015. *Estudio de Evaluación de los Servicios de las EPS por Parte de los Usuarios, en el Régimen Contributivo y Subsidiado: Informe de Resultados*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/estudio-evaluacion-servicios-eps.pdf>.

Cressie, Noel, y Timothy R. C. Read. 1984. «Multinomial Goodness-of-Fit Tests». *Journal of the Royal Statistical Society. Series B* 46 (3): 440-64.

Defensoría del Pueblo de Colombia. 2009. *Evaluación de los Servicios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) desde la Perspectiva del Usuario*. Defensoría del Pueblo de Colombia.

Deville, Jean-Claude, y Carl-Erik Särndal. 1992. «Calibration Estimators in Survey Sampling». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418): 376-82.

Efron, Bradley, y Robert J. Tibshirani. 1993. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.

- Elliott, Michael R., y Richard Valliant. 2017. «Calibration weighting for non-probability samples». *Statistical Science* 32 (2): 249-64.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. Wiley.
- Lee, Sunghee, y Richard Valliant. 2006. *Propensity Score Adjustment for Nonresponse in Surveys*. RTI Press.
- Lohr, Sharon L. 2021. *Sampling: Design and Analysis*. 3.^a ed. CRC Press.
- Matajira Gaitán, Camilo, Eric Barney Iglesias, Wilman Bonett Molina, y Germán Escobar Morales. 2018. *Sistema de Evaluación y Calificación de Actores: Ranking de Satisfacción EPS 2018*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf>.
- Ministerio de la Protección Social. 2006. *Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud*. Ministerio de la Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/decreto/%201011/%20de/%202006.pdf.
- Ministerio de la Protección Social. 2008. *PECASUSS: Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud*. Ministerio de la Protección Social.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2016a. *Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/Normativa/paginas/decreto-unico-minsalud-780-de-2016.aspx>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2016b. *Encuesta de Evaluación de los Servicios de las EPS: Informe Final*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-servicios-eps-2016.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2016c. *Resolución 256 de 2016, por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/abece-resolucion-256-de-2016.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2017. *Encuesta Nacional de*

Evaluación de los Servicios de las EPS: Informe Final Colombia 2017. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Informe-encuesta-satisfaccion-eps-2017.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2020. *Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS – Régimen Contributivo y Subsidiado 2020: Informe Final.* Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-eps-2020-minsalud.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2022. *Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS – 2022.* Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/encuesta-satisfaccion-servicios-eps-2022.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2023. *Resultados de la Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano con Énfasis en Atención Primaria en Salud.* Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/resultados-encuesta-satisfaccion-usuarios-sistema-salud-colombiano-enfasis-atencion-primaria.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2024. *Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2024.* Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/Publicaciones.aspx>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2025. *Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2025.* Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/informe-encuesta-satisfaccion-2025.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2026. *Resolución 1642 de 2026, por la cual se actualizan las reglas para la elaboración, entrega y divulgación de la Carta de Derechos y Deberes de las personas afiliadas al sistema de salud y se adopta la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS) como instrumento oficial y permanente de medición del desempeño de las EPS y demás actores del sistema.* Ministerio de Salud y Protección Social.

OECD. 2025. *Does Healthcare Deliver? Results from the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS).* OECD Publishing. <https://www.oecd.org/en/>

[publications/does-healthcare-deliver_c8af05a5-en.html](#).

Rao, J. N. K., y C. F. J. Wu. 1988. «Resampling Inference with Complex Survey Data». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 231-41.

Wang, Wei, y Richard Valliant. 2015. «Propensity Score Adjustment for Web Surveys». *Journal of Survey Statistics and Methodology* 3 (2): 147-70.

World Health Organization. 2000. *The World Health Report 2000: Health Systems – Improving Performance*. World Health Organization.